RESUMEN EPICRISIS

PACIENTE: SANTIAGO GARCIA PAPAMIJA	**IDENTIFICACION:** TI 1109922924	**HC:** 1109922924 - TI
FECHA DE NACIMIENTO: 5/7/2010 **EDAD:** 15 Años **SEXO:** M		**TIPO AFILIADO:** Otro
RESIDENCIA: CARRERA 42A 56D 05	VALLE DEL CAUCA-CALI	**TELEFONO:** 3128845383
ESTADO CIVIL: SOLTERO(A)	**OCUPACIÓN:** SIN INFORMACION	
NOMBRE ACOMPAï¿½ANTE:	**PARENTESCO:**	**TELEFONO:**
FECHA INGRESO: 07/03/2026 08:12 PM	**FECHA EGRESO:**	**CAMA:** UCP303
DEPARTAMENTO: UCIPED - UCI PEDIATRICA	**SERVICIO:** U.C.I.	
CLIENTE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	**PLAN:** ASEG SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOP-2026	

FECHA	MOTIVOS DE CONSULTA Y ENFERMEDAD ACTUAL
2026-03-07	**21:21 johmonmi - JOHN CARLOS MONSALVE MIRANDA** **CAUSA QUE MOTIVA LA ATENCIÓN:** Otro tipo de accidente **MOTIVO DE CONSULTA :** INGRESA PACIENTE EN COMPAÑIA DE LA MADRE Y PERSONAL PARAMEDICO POR PRESENTAR TRAUMA EN CRANEO Y HOMBRO DERECHO DURANTE ACCIDENTE DE TRANSITO DE ALTA CINEMATICA **ENFERMEDAD ACTUAL :** INGRESA PACIENTE EN COMPAÑIA DE LA MADRE Y PERSONAL PARAMEDICO POR PRESENTAR TRAUMA EN CRANEO Y HOMBRO DERECHO DURANTE ACCIDENTE DE TRANSITO DE ALTA CINEMATICA, LESIONES EN CARA Y MIEMBROS, REFIERE DOLOR A LOS ARCOS DE MOVIMIENTO DEL HOMRBO DERECHO Y CEFALEA, NIEGA PERDIDA DEL CONOCIMIENTO, EMESIS, CONVULSIONES U OTROS SIGNOS DE ALARMA NEUROLOGICOS, NIEGA DIFICULTAD RESPIRATORIA U OTRO SIGNO DE ALARMA.

DIAGNOSTICOS DE INGRESO ASIGNADOS

CODIGO	DIAGNOSTICO DE INGRESO	ESTADO	OBSERVACION	USUARIO	FECHA
S018	HERIDA DE OTRAS PARTES DE LA CABEZA			JOHN CARLOS MONSALVE MIRANDA	2026-03-07
S099	TRAUMATISMO DE LA CABEZA NO ESPECIFICADO			JOHN CARLOS MONSALVE MIRANDA	2026-03-07
S199	TRAUMATISMO DEL CUELLO NO ESPECIFICADO			JOHN CARLOS MONSALVE MIRANDA	2026-03-07
S499	TRAUMATISMOS NO ESPECIFICADOS DEL HOMBRO Y DEL BRAZO			JOHN CARLOS MONSALVE MIRANDA	2026-03-07
S027	FRACTURAS MULTIPLES QUE COMPROMETEN EL CRANEO Y LOS HUESOS DE LA CARA			SEBASTIAN MONTES VILLEGAS	2026-03-09

MOTIVO DE SALIDA Y RECOMENDACIONES

2026-03-07 21:31 **PROFESIONAL:** johmonmi - JOHN CARLOS MONSALVE MIRANDA **ESPECIALIDAD:** PEDIATRIA

****VALORACION DE URGENCIAS POR PEDIATRA******

NOMBRE: SANTIAGO GARCIA PAPAMIJA
EDAD: 15 AÑOS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: TI 1109922924
ACUDIENTE: LEIDY PAPAMIJA (MADRE) - CC: 38669808
ASEGURADOR: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA
FECHA DE INGRESO A URGENCIAS: 07/03/2026

MOTIVO DE CONSULTA: "INGRESA PACIENTE EN COMPAÑIA DE LA MADRE Y PERSONAL PARAMEDICO POR PRESENTAR TRAUMA EN CRANEO Y HOMBRO DERECHO DURANTE ACCIDENTE DE TRANSITO DE ALTA CINEMATICA"

ENFERMEDAD ACTUAL: INGRESA PACIENTE EN COMPAÑIA DE LA MADRE Y PERSONAL PARAMEDICO POR PRESENTAR TRAUMA EN CRANEO Y HOMBRO DERECHO DURANTE ACCIDENTE DE TRANSITO DE ALTA CINEMATICA, LESIONES EN CARA Y MIEMBROS, REFIERE DOLOR A LOS ARCOS DE MOVIMIENTO DEL HOMRBO DERECHO Y CEFALEA, NIEGA PERDIDA DEL CONOCIMIENTO, EMESIS, CONVULSIONES U OTROS SIGNOS DE ALARMA NEUROLOGICOS, NIEGA DIFICULTAD RESPIRATORIA U OTRO SIGNO DE ALARMA.

REVISIÓN POR SISTEMAS:
SINTOMAS GASTROINTESTINALES: NO REFIERE

DIURESIS: CLARA, NO CAMBIOS MACROSCÓPICOS, NO SÍNTOMAS IRRITATIVOS
SÍNTOMAS CARDIOVASCULARES: NO REFIERE
SÍNTOMAS NEUROLOGICOS: NO REFIERE
LESIONES EN PIEL: NO REFIERE

ANTECEDENTES:
PATOLÓGICOS: NIEGA
FARMACOLÓGICOS: NIEGA
QUIRÚRGICOS: NIEGA
TRAUMATICOS: NIEGA
VACUNACIÓN: COMPLETAS PARA LA EDAD NO TRAE CARNET
TÓXICO: NIEGA
ALÉRGICOS: NIEGA
FAMILIARES: NIEGA
GINECOLOGICOS: NO APLICA

PROTOCOLO COVID:
1. ¿HA TENIDO SÍNTOMAS RESPIRATORIOS EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS? NIEGA.
2. ¿HA VIAJADO EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS? NIEGA.
3. ¿HA TENIDO CONTACTO CON ALGÚN CASO SOSPECHOSO O CONFIRMADO PARA COVID? NIEGA.

PROTOCOLO ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS:
HA PRESENTADO DURANTE LOS ÚLTIMOS DÍAS UNO O VARIOS DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS:
-FIEBRE O MÁS? NIEGA.
-TOS POR MÁS DE 15 DÍAS? NIEGA.
-CEFALEA? NIEGA.
-PÉRDIDA DEL GUSTO Y EL OLFATO? NIEGA.
-CONJUNTIVITIS? NIEGA.
-CRECIMIENTO DE GANGLIOS LINFÁTICOS? NIEGA.
-LESIONES EN PIEL: MÁCULAS, PÁPULAS, VESÍCULAS, PÚSTULAS O ÚLCERAS GENITALES? NIEGA.

1. ¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 21 DÍAS HA TENIDO CONTACTO ESTRECHO CON UNA PERSONA PROBABLE O CONFIRMADA PARA VIRUELA DEL MONO? NIEGA.
2. ¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS SE HA DESPLAZADO A ZONAS ENDÉMICAS PARA VIRUELA DEL MONO? NIEGA.
3. ¿VIVE USTED O SE HA ENCONTRADO EN CONDICIONES DE HACINAMIENTO? NIEGA.
4. ¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS HA TENIDO CONTACTO ESTRECHO (< A 1 METRO DE DISTANCIA) CON UNA PERSONA PROBABLE O CONFIRMADA PARA COVID 19? NIEGA.
5. ¿ES TRABAJADOR DE LA SALUD? NIEGA.
6. ¿ES TRABAJADOR DEL SECTOR AVÍCOLA O PORCINO ? ¿ O HA ESTADO EN CONTACTO CON AVES O CERDOS EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS? NIEGA.
7. ¿HA VIAJADO EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS A ÁREAS DE CIRCULACIÓN DE VIRUS DE INFLUENZA AVIAR O AGENTES RESPIRATORIOS NUEVOS CON POTENCIAL PANDÉMICO? NIEGA.
8. ¿HA ESTADO EN CONTACTO CON PERSONAS O GRUPOS SOCIALES(ENTORNOS FAMILIARES,LUGAR DE TRABAJO, COLEGIOS,UNIVERSIDADES, CARCEL, BATALLÓN) CON SÍNTOMAS RESPIRATORIOS? NIEGA.

CONCILIACIÓN MEDICAMENTOSA: NIEGA.

OBJETIVO:
ASPECTO: PACIENTE QUIEN INGRESA EN SILLA DE RUEDAS SE MOVILIZA SIN LIMITACIONES INTERACTUA CON EL MEDIO Y EL EXAMINADOR SIN DISTRES RESPIRATORIO NO LUCE TOXICO
ANTROPOMETRIA:
PESO: 65 KGS, TALLA: 170 CMS, IMC: 22.49
SIGNOS VITALES: FRECUENCIA CARDIACA 68 LATIDOS MINUTOS, FRECUENCIA RESPIRATORIA 20 RESPIRACIONES MINUTO, TENSION ARTERIAL 106/66 MMHG, TEMPERATURA 35.6°c, SATURACION 96% AL AMBIENTE.
ESCALA VISUAL ANALOGA: 4/10
CABEZA: NORMOCEFALA HEMATOMA Y HERIDA COMPLEJA FRONTAL DERECHA EQUIMOSIS PERIORBITARIA Y EDEMA BIPALPEBRAL DERECHO LEVE ABRASION POMULO DERECHO CONJUNTIVAS ROSADAS ESCLERAS BLANCAS OROFARINGE NORMAL MUCOSA ORAL HUMEDA CUELLO SIMETRICO SIN ESTIGMAS DE TRAUMA TRAQUEA CENTRAL SIN MASAS NI ADENOPATIAS NO SE EVALUAN ARCOS DE MOVIMIENTO DEL CUELLO PARA EVITAR PROGRESION DE LESIONES
TÓRAX: SIMETRICO NORMOEXPANSIBLE SIN ESTIGMAS DE TRAUMA NO HAY SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS MURMULLO VESICULAR PRESENTE BILATERAL SIN SOBREAGREGADOS
ABDOMEN: BLANDO DEPRESIBLE SIN ESTIGMAS DE TRAUMA SIN MASAS SIN MEGALIAS SIN DOLOR A LA PALPACION SUPERFICIAL NI PROFUNDA SIN SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL
GENITOURINARIO: SE OMITE EVALUACION DE GENITALES
EXTREMIDADES: DOLOR A LOS ARCOS DE MOVIMIENTO DEL HOMBRO DERECHO ARTICULACIONES Y EXTREMIDADES EUTROFICAS SIN DEFORMIDADES O LIMITACION A LOS ARCOS DE MOVIMIENTO PASIVOS O ACTIVOS CON LLENADO CAPILAR MENOR A 2 SEGUNDOS PULSOS SIMETRICOS BILATERALES DE BUENA AMPLITUD
DORSO: SIN LESIONES VISIBLES
PIEL: ABRASION HOMBRO DERECHO
NEUROLÓGICO: ALERTA ACTIVO ADECUADO CONTACTO CON EXAMINADOR PUPILAS SIMETRICAS DE 3 MM NORMORREACTIVAS REFLEJOS NORMALES EN 4 EXTREMIDADES FUERZA NORMAL SIN ALTERACION SENSITIVA NO REFLEJOS PATOLOGICOS NO MOVIMIENTOS ANORMALES NO SIGNOS DE IRRITACION MENINGEA GLASGOW 15/15

DIAGNÓSTICOS:
1. ADOLESCENTE MASCULINO
2. TRAUMA CRANEO ENCEFALICO
3. TRAUMA EN CARA
3.1. HERIDA FRONTAL DERECHA
3.2. DESCARTAR FRACTURA DE LA ORBITA
4. TRAUMA EN HOMBRO DERECHO
5. ACCIDENTE DE TRANSITO

ANÁLISIS:
SANTIAGO ES UN ADOLESCENTE MASCULINO DE 14 AÑOS QUIEN INGRESA POR TRAUMA EN CRANEO, CARA Y HOMBRO DERECHO DURANTE ACCIDENTE DE TRANSITO DE ALTA CINEMATICA; A LA EVALUACION SIN DISTRES RESPIRATORIO, SIN REQUERIMIENTO DE OXIGENO, SIN COMPROMISO HEMODINAMICO, SIN SIGNOS DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA, SIN EDEMA O LIMITACION FUNCIONAL EN OTROS MIEMBROS DIFERENTES AL HOMBRO DERECHO, SIN SIGNOS DE COMPROMISO VASCULAR, SIN SIGNOS DE COMPROMISO NEUROLOGICO. SE INDICA INGRESO A OBSERVACION, SE INDICA ANALGESIA, COBERTURA ANTIBIOTICA, PROFILAXIS ANTITETANICA Y LIQUIDOS ENDOVENOSOS, SE SOLICITAN TOMOGRAFIAS SIMPLES DE CRANEO, CUELLO Y ORBITA DERECHA PARA DESCARTAR FRACTURAS O LESIONES INTRACRANEALES O MEDULARES, SE SOLICITA Rx DEL HOMBRO DERECHO PARA DESCARTAR FRACTURAS O ALTERACION DE LAS RELACIONES ARTICULARES, SE SOLICITAN PARACLINICOS PREQUIRURGICOS Y CONCEPTO DE CIRUGIA PLASTICA, PARA EVALUAR MEDIDAS COMPLEMENTARIAS, SE EXPLICA A LA MADRE DEL PACIENTE EL PLAN, REFIERE ENTENDER Y ESTA DE ACUERDO.

PLAN:
PESO: 65 KGS
-INGRESAR A SALA DE OBSERVACION PEDIATRIA
-NADA VIA ORAL
-L.E.V.: LACTATO DE RINGER INFUSION CONTINUA A 80 CC HORA
-DICLOFENAC AMP 75 MG: DILUIR EN 100 CC DE SSN Y ADMINISTRAR EN INFUSION ENDOVENOSA DE 20 MIN AHORA
-DIPIRONA AMP 1 GR: DILUIR HASTA 100 CC EN SSN Y ADMINISTRAR EN INFUSION ENDOVENOSA DE 20 MIN CADA 6 HORAS
-CEFAZOLINA AMP 1 GR: ADMINISTRAR 1 GR ENDOVENOSO LENTO CADA 6 HORAS
-TOXOIDE TETANICO AMP 40 UI: ADMINISTRAR INTRAMUSCULAR DOSIS UNICA
-CUIDADOS POR ENFERMERÍA
-CONTROL DE SIGNOS VITALES CADA 4 HORAS
-CURACION DE LESIONES EN PIEL POR ENFERMERIA
-HOJA NEUROLOGICA HORARIA
-SS: HEMOGRAMA Y TIEMPOS DE COAGULACION
-SS: TOMOGRAFIAS SIMPLES DE CRANEO, CUELLO Y ORBITA DERECHA
-SS: Rx DEL HOMBRO DERECHO
-SS: Vx CIRUGIA PLASTICA
-SEGUIMIENTO POR PEDIATRIA / MED GENERAL
-GRACIAS

2026-03-08 03:31	**PROFESIONAL:** johmonmi - JOHN CARLOS MONSALVE MIRANDA	**ESPECIALIDAD:** PEDIATRIA

*****NOTA DE SEGUIMIENTO POR PEDIATRA*****

NOMBRE: SANTIAGO GARCIA PAPAMIJA
EDAD: 15 AÑOS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: TI 1109922924
ACUDIENTE: LEIDY PAPAMIJA (MADRE) - CC: 38669808
ASEGURADOR: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA
FECHA DE INGRESO A URGENCIAS: 07/03/2026

SUBJETIVO: PACIENTE EN COMPAÑIA DE LA MADRE, PERSISTE CON CEFALEA, NO SE REPORTA ALTERACION DEL ESTADO DE CONCIENCIA, EMESIS, CONVULSIONES U OTROS SIGNOS DE ALARMA NEUROLOGICOS, NIEGA DIFICULTAD RESPIRATORIA U OTRO SIGNO DE ALARMA, TOLERA VIA ORAL.

IMAGENES:

RADIOGRAFIA DE HOMBRO DERECHO
EN ESPERA DE LECTURA SIN APARENTES SIGNOS RADIOLOGICOS DE FRACTURAS O ALTERACION DE LAS RELACIONES ARTICULARES

TAC DE CRANEO SIMPLE
EN ESPERA DE LECTURA CON APARENTES SIGNOS TOMOGRAFICOS DE FRACTURA DEL SENO FRONTAL DERECHO Y ETMOIDAL CON NEUMOENCEFALO SIN LESIONES INTRACRANEALES

TAC DE ORBITA
EN ESPERA DE LECTURA CON APARENTES SIGNOS TOMOGRAFICOS DE FRACTURA DEL PISO DE LA ORBITA

TAC DE COLUMNA CERVICAL
EN ESPERA DE LECTURA SIN APARENTES SIGNOS TOMOGRAFICOS DE FRACTURAS DE LA COLUMNA CERVICAL

OBJETIVO:
ASPECTO: PACIENTE EN CAMILLA EN BUENAS CONDICIONES GENERALES CAMINA SIN LIMITACIONES, MODULA EL DOLOR, INTERACTUA CON EL MEDIO Y EL EXAMINADOR SIN DISTRES RESPIRATORIO NO LUCE TOXICO
ANTROPOMETRIA:
PESO: 65 KGS, TALLA: 170 CMS, IMC: 22.49
SIGNOS VITALES: FRECUENCIA CARDIACA 68 LATIDOS MINUTOS, FRECUENCIA RESPIRATORIA 20 RESPIRACIONES MINUTO, TENSION ARTERIAL 106/66 MMHG, TEMPERATURA 35.6°c, SATURACION 96% AL AMBIENTE.
ESCALA VISUAL ANALOGA: 4/10
CABEZA: NORMOCEFALA HEMATOMA Y HERIDA COMPLEJA FRONTAL DERECHA EQUIMOSIS PERIORBITARIA Y EDEMA BIPALPEBRAL DERECHO LEVE ABRASION POMULO DERECHO CONJUNTIVAS ROSADAS ESCLERAS BLANCAS OROFARINGE NORMAL MUCOSA ORAL HUMEDA CUELLO SIMETRICO SIN ESTIGMAS DE TRAUMA TRAQUEA CENTRAL SIN MASAS NI ADENOPATIAS NO SE EVALUAN ARCOS DE MOVIMIENTO DEL CUELLO PARA EVITAR PROGRESION DE LESIONES
TÓRAX: SIMETRICO NORMOEXPANSIBLE SIN ESTIGMAS DE TRAUMA NO HAY SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS MURMULLO VESICULAR PRESENTE BILATERAL SIN SOBREAGREGADOS
ABDOMEN: BLANDO DEPRESIBLE SIN ESTIGMAS DE TRAUMA SIN MASAS SIN MEGALIAS SIN DOLOR A LA PALPACION SUPERFICIAL NI PROFUNDA SIN SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL
GENITOURINARIO: SE OMITE EVALUACION DE GENITALES
EXTREMIDADES: DOLOR A LOS ARCOS DE MOVIMIENTO DEL HOMBRO DERECHO ARTICULACIONES Y EXTREMIDADES EUTROFICAS SIN DEFORMIDADES O LIMITACION A LOS ARCOS DE MOVIMIENTO PASIVOS O ACTIVOS CON LLENADO CAPILAR MENOR A 2 SEGUNDOS PULSOS SIMETRICOS BILATERALES DE BUENA AMPLITUD
DORSO: SIN LESIONES VISIBLES

PIEL: ABRASION HOMBRO DERECHO
NEUROLÓGICO: ALERTA ACTIVO ADECUADO CONTACTO CON EXAMINADOR PUPILAS SIMETRICAS DE 3 MM NORMORREACTIVAS REFLEJOS NORMALES EN 4 EXTREMIDADES FUERZA NORMAL SIN ALTERACION SENSITIVA NO REFLEJOS PATOLOGICOS NO MOVIMIENTOS ANORMALES NO SIGNOS DE IRRITACION MENINGEA GLASGOW 15/15

DIAGNÓSTICOS:
1. ADOLESCENTE MASCULINO
2. TRAUMA CRANEO ENCEFALICO
2.1. FRACTURA SENO FRONTAL DERECHO
2.2. FRACTURA EL SENO ETMOIDAL DERECHO
2.3. NEUMOENCEFALO
3. TRAUMA EN CARA
3.1. HERIDA FRONTAL DERECHA
3.2. FRACTURA DEL PISO DE LA ORBITA
4. TRAUMA EN HOMBRO DERECHO
5. ACCIDENTE DE TRANSITO

ANALISIS:
SANTIAGO ES UN ADOLESCENTE MASCULINO DE 14 AÑOS QUIEN INGRESA POR TRAUMA EN CRANEO, CARA Y HOMBRO DERECHO DURANTE ACCIDENTE DE TRANSITO DE ALTA CINEMATICA. EVALUO TAC DE CRANEO SIMPLE EN ESPERA DE LECTURA CON APARENTES SIGNOS TOMOGRAFICOS DE FRACTURA DEL SENO FRONTAL DERECHO Y ETMOIDAL CON NEUMOENCEFALO SIN LESIONES INTRACRANEALES, TAC DE ORBITA EN ESPERA DE LECTURA CON APARENTES SIGNOS TOMOGRAFICOS DE FRACTURA DEL PISO DE LA ORBITA, TAC DE COLUMNA CERVICAL EN ESPERA DE LECTURA SIN APARENTES SIGNOS TOMOGRAFICOS DE FRACTURAS DE LA COLUMNA CERVICAL Y RADIOGRAFIA DE HOMBRO DERECHO EN ESPERA DE LECTURA SIN APARENTES SIGNOS RADIOLOGICOS DE FRACTURAS O ALTERACION DE LAS RELACIONES ARTICULARES; SE COMENTA CON NEUROCIRUGIA (Dr JORGE ORDOÑEZ) QUIEN INDICA MONITORIA NEUROLOGICA Y TOMOGRAFIA DE CONTROL EN 12 HORAS, CONDUCTAS COMPLEMENTARIAS POR MAXILOFACIAL. PACIENTE A LA EVALUACION EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, ALGICO, SIN DISTRES RESPIRATORIO, SIN REQUERIMIENTO DE OXIGENO, SIN COMPROMISO HEMODINAMICO, SIN SIGNOS DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA, SIN EDEMA O LIMITACION FUNCIONAL EN MIEMBROS, SIN SIGNOS DE COMPROMISO VASCULAR, SIN SIGNOS DE COMPROMISO NEUROLOGICO. SE INDICA HOSPITALIZAR EN CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRICO PARA MONITORIA NEUROLOGICA, MANEJO MEDICO IGUAL, SE INFORMA EL PLAN AL ACOMPAÑANTE, REFIERE ENTENDER Y ESTA DE ACUERDO.

PLAN:
PESO: 65 KGS
-HOSPITALIZAR EN CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRICO
-NADA VIA ORAL
-L.E.V.: LACTATO DE RINGER INFUSION CONTINUA A 80 CC HORA
-DICLOFENAC AMP 75 MG: DILUIR EN 100 CC DE SSN Y ADMINISTRAR EN INFUSION ENDOVENOSA DE 20 MIN CADA 12 HORAS
-DIPIRONA AMP 1 GR: DILUIR HASTA 100 CC EN SSN Y ADMINISTRAR EN INFUSION ENDOVENOSA DE 20 MIN CADA 6 HORAS
-CEFAZOLINA AMP 1 GR: ADMINISTRAR 1 GR ENDOVENOSO LENTO CADA 6 HORAS
-CUIDADOS POR ENFERMERÍA
-MONITORIA CONTINUA DE SIGNOS VITALES
-HOJA NEUROLOGICA HORARIA
-SS: Vx CIRUGIA MAXILOFACIAL
-SS: TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE DE CONTROL A LAS 13:00
-PTE: NOTA FORMAL DE NEUROCIRUGIA
-PTE: HEMOGRAMA Y TIEMPOS DE COAGULACION
-PTE: LECTURA DE TOMOGRAFIAS SIMPLES DE CRANEO, CUELLO Y ORBITA DERECHA
-PTE: LECTURA DE Rx DEL HOMBRO DERECHO
-SEGUIMIENTO POR PEDIATRIA / MED GENERAL
-GRACIAS

2026-03-08 05:26	**PROFESIONAL:** diadonca - DIANA MARCELA DONNEYS CASTAÑO	**ESPECIALIDAD:** PEDIATRIA

*** INGRESO UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS **
DRA DIANA DONNEYS (MD ESPECIALISTA)

NOMBRE: SANTIAGO GARCIA PAPAMIJA
EDAD: 15 AÑOS
DOCUMENTO: 1109922924
ENTIDAD: SOAT
ACUDIENTE: MADRE
FECHA DE INGRESO A URGENCIAS: 07/03/2026
FECHA DE INGRESO UCI: 08/03/2026

* MOTIVO DE CONSULTA

ACCIDENTE DE TRÁNSITO

* ENFERMEDAD ACTUAL:

PACIENTE QUIEN INGRESA EN COMPAÑIA DE LA MADRE Y PERSONAL PARAMÉDICO POR PRESENTAR TRAUMA EN CRANEO Y HOMBRO DERECHO DURANTE ACCIDENTE DE TRANSITO DE ALTA CINEMÁTICA, LESIONES EN CARA Y MIEMBROS, REFIERE DOLOR A LOS ARCOS DE MOVIMIENTO DEL HOMBRO DERECHO Y CEFALEA, NIEGA PERDIDA DEL CONOCIMIENTO, EMESIS, CONVULSIONES U OTROS SIGNOS DE ALARMA NEUROLÓGICOS, NIEGA DIFICULTAD RESPIRATORIA U OTRO SIGNO DE ALARMA. AL INGRESO DESCRIBEN HEMATOMA Y HERIDA COMPLEJA FRONTAL DERECHA EQUIMOSIS PERIORBITARIA Y EDEMA PALPEBRAL DERECHO LEVE ABRASIÓN POMULO , GLASGOW 15/15, TOMAN IMÁGENES:

RX DE HOMBRO DERECHO: RELACIONES ARTERIALES CONSERVADAS, NO SE OBSERVA TRAZO DE FRCTURA EN CLAVÍCULA DERECHA EN PROCESO REPORTE OFICIAL
TAC CERVICAL NO SE EVIDENCIA TRAZOS DE FRACTURA (PENDIENTE LECTURA OFICIAL)
TAC DE CARA IMAGEN SUGESTIVA DE FRACTURA DE PISO DE LA ORBITA DERECHA,TRAZO DE FRACTURA EN SENO FRONTAL IPSILATERAL. PENDIENTE LECTURA OFICIAL
TAC DE CRANEO: SE EVIDENCIA NEUMOENCEFALO PEQUEÑO A NIVEL FRONTAL CON CONTUSIÓN HEMORRÁGICA ASOCIADA , SIN EVIDENCI

A DE HEMATOMA NI HEMORRAGIA, LINEA MEDIA CENTRADA . NO LESIONES OCUANTES DE ESPACIO, PENDIENTE LECTURA OFICIAL

SE COMENTA CON NEUROCIRUGIA (Dr JORGE ORDOÑEZ) QUIEN INDICA MONITORIA NEUROLOGICA Y TOMOGRAFÍA DE CONTROL EN 12 HORAS, CONDUCTAS COMPLEMENTARIAS POR MAXILOFACIAL. DADO HALLAZGOS EN IMÁGENES ALTO RIESGO DE DETERIORO NEUROLÓGICO, POR LO CUAL SE TRASLADA A UCIN PARA MONITOREO NEUROCRITICO NO INVASIVO. ,

REVISIÓN POR SISTEMAS: NIEGA OTROS TRAUMAS, NIEGA OTROS SINTOMAS.

ANTECEDENTES:
*PATOLÓGICOS FAMILAIR NIEGA
*FARMACOLÓGICOS: FAMILAIR NIEGA
*QUIRÚRGICOS: FAMILAIR NIEGA
*HOSPITALIZACIONES: FAMILAIR NIEGA
*ALERGIAS: FAMILAIR NIEGA
*VACUNAS: REFIERE COMPLETAS NO APORTA CARNET

PROTOCOLO COVID:
1. ¿HA TENIDO SÍNTOMAS RESPIRATORIOS EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS? NIEGA.
2. ¿HA VIAJADO EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS? NIEGA.
3. ¿HA TENIDO CONTACTO CON ALGÚN CASO SOSPECHOSO O CONFIRMADO PARA COVID? NIEGA.

PROTOCOLO ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS:
HA PRESENTADO DURANTE LOS ÚLTIMOS DÍAS UNO O VARIOS DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS:
-FIEBRE O MÁS? NIEGA.
-TOS POR MÁS DE 15 DÍAS? NIEGA.
-CEFALEA? NIEGA
-PÉRDIDA DEL GUSTO Y EL OLFATO? NIEGA.
-CONJUNTIVITIS? NIEGA.
-CRECIMIENTO DE GANGLIOS LINFÁTICOS? NIEGA.
-LESIONES EN PIEL: MÁCULAS, PÁPULAS, VESÍCULAS, PÚSTULAS O ÚLCERAS GENITALES? NIEGA.

1. ¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 21 DÍAS HA TENIDO CONTACTO ESTRECHO CON UNA PERSONA PROBABLE O CONFIRMADA PARA VIRUELA DEL MONO? NIEGA.
2. ¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS SE HA DESPLAZADO A ZONAS ENDÉMICAS PARA VIRUELA DEL MONO? NIEGA.
3. ¿VIVE USTED O SE HA ENCONTRADO EN CONDICIONES DE HACINAMIENTO? NIEGA.
4. ¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS HA TENIDO CONTACTO ESTRECHO (< A 1 METRO DE DISTANCIA) CON UNA PERSONA PROBABLE O CONFIRMADA PARA COVID 19? NIEGA.
5. ¿ES TRABAJADOR DE LA SALUD? NIEGA.
6. ¿ES TRABAJADOR DEL SECTOR AVÍCOLA O PORCINO ? ¿ O HA ESTADO EN CONTACTO CON AVES O CERDOS EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS? NIEGA.
7. ¿HA VIAJADO EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS A ÁREAS DE CIRCULACIÓN DE VIRUS DE INFLUENZA AVIAR O AGENTES RESPIRATORIOS NUEVOS CON POTENCIAL PANDÉMICO? NIEGA.
8. ¿HA ESTADO EN CONTACTO CON PERSONAS O GRUPOS SOCIALES(ENTORNOS FAMILIARES,LUGAR DE TRABAJO, COLEGIOS,UNIVERSIDADES, CARCEL, BATALLÓN) CON SÍNTOMAS RESPIRATORIOS? NIEGA.

EXAMEN FÍSICO:
PESO 65 KGS

PRESIÓN ARTERIAL: 118/51 MMHG (71 MMHG)
FRECUENCIA CARDIACA: 89 LPM
FRECUENCIA RESPIRATORIA 18 RXM
SATURACION DE O297 %
TEMPERATURA 36.5 °C

- HEMODINAMICO: SIN SOPORTE VASAOCTIVO, SIN SIGNOS DE BAJO GASTO, NO FRIALDAD DISTAL, LLENADO CAPILAR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS SIMETRICOS REGULARES, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS
- RESPIRATORIO: TORAX SIMETRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO,
- GASTROINTESTINAL: ABDOMEN NO DISTENDIDO, BLANDO, DEPRESIBLE, SIN LLANTO A LA PALPACION, NO IRRITACION PERITONEAL.
- RENAL: MICCION ESPONTANEA, ORINA CLARA, NO EDEMAS.
- METABOLICO: TOLERANDO VIA ORAL, NO EMESIS, GLUCOMETRIA 108 MG/DL
- HEMATOLOGICO: NO SANGRADO, NO HEMATOMAS
- INFECCIOSO: NO PICOS FEBRILES
- NEUROLOGICO: ALERTA, ACTIVO, REACTIVO, SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE
-PIEL: HERIDA COMPLEJA FRONTAL DERECHO CON BORDES IRREGULARES DE PAROXIDAMENTE 4*4 CM , CON DEPRESION EN ZONA , NO SANGRADO ACTIVO. EDEMA Y EQUIMOSIS PALPEBRAL ASOCIADA

* DIAGNOSTICOS
POLITRAUMATISMO POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO
TRAUMA CRANEO ENCEFALICO LEVE CON RIESGO MODERADO POR CINEMATICA DEL TRAUMA
-NEUMOENCÉFALO
TRAUMA FACIAL
SOSPECHA FRACTURA SENO FRONTAL DERECHO
SOSPECHA FRACTURA DE PISO DE LA ORBITA
HERIDA FRONTAL DERECHA COMPLEJA
TRAUMA EN HOMBRO DERECHO

* CRITERIOS UCI
.- MONITORIA RESPIRATORIA, HEMODINÁMICA
-MONITOREO NEUROCRITICO

* ANALISIS
PACIENTE DE 15 AÑOS, POLITRAUMATISMO POR ACCIDENTE DE TRANSITO, AHORA CON LOS SIGUIENTES PROBLEMAS:
*TRAUMA CRANEO ENCEFALICO LEVE CON RIESGO MODERADO POR CINEMATICA DEL TRAUMA, TAC DE CRANEO SE EVIDENCIA NEUMOENCEFALO PEQUEÑO A NIVEL FRONTAL CON CONTUSIÓN HEMORRÁGICA ASOCIADA , SIN EVIDENCI A DE HEMATOMA NI HEMORRAGIA, LINEA MEDIA CENTRADA . NO LESIONES OCUPANTES DE ESPACIO, PENDIENTE LECTURA OFICIAL. EN EL MOMENTO SI SIGNOS DE HIPERTENSIÓN ENDOCRANEANA. GLASGOW 15/15. EN SEGUIMIENTO POR NEUROCIRUGIA DR, ORDOÑEZ QUIEN DINCA TAC DE CRANEO DE CONTROL EN 12 HORAS . REQUIRE MONITOREO NEUROCRITICO.
* TRAUMA FACIAL IMAGEN SUGESTIVA DE FRACTURA DE PISO DE LA ORBITA DERECHA,TRAZO DE FRACTURA EN SENO FRONTAL IPSILATERAL. PENDIENTE LECTURA OFICIAL PACIENTE CON HERIDA COMPLEJA A NIVEL FRONTAL, NO SE DESCARTA FRACTURA ABIERTA POR LO QUE SE INCIA CUBRIMIENTO ANTIBIÓTICO CON AMPICILINA SULBACTAM EN PROCESO CONCEPTO DE CIRUGÍA MAXILOFACIAL Y CIRUGÍA PLÁSTICA.
*TRAUMA EN HOMBRO DERECHO: RX DE HOMBRO DERECHO: RELACIONES ARTERIALES CONSERVADAS, NO SE OBSERVA TRAZO DE FRACTURA EN CLAVÍCULA DERECHA EN PROCESO REPORTE OFICIAL . DOLOR EN ARCOS DE MOVILIDAD , EVA 3/10, EN ESPERA DE REPORTE OFICIAL DE RX PARA DEFINIR CONDUCTA.

EN EL MOMENTO PACIENTE HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE, SIN SIGNOS DE BAJO GAST, FRECUENCIA CARDIACA Y TENSIONES ARTERIALES EN METAS, REQUIERE MONITOREO UCIN DADO RIESGO DE DETERIOR NEUROLÓGICO,HEMODINÁMICO . SE EXPLICA A LA MADRE QUIEN ENTIENDE Y ACEPTA.

PLAN
PESO 65 KG
LEV TOTAL 80 CC / H

-VIA OAL CON DIETA BLANDA VIGILANDO TOLERANCIA
-CABECERA A 45 GRADOS
-LACTATO PARA COMPLETAR APORTE HÍDRICO
-AMPICILINA / SULBACTAM 3 GR CADA 6 HORAS FI: 08/03/2026
-DIPIRONA 1 GR EV CADA 8 HORAS
-PARACETAMOL 1 GR CADA 6 HORAS
-MORFINA 3 MG EV CADA 4 HORAS SI EVA >4, MAXIMO 4 DOSIS DE RESCATE
-HOJA NEUROLOICA CADA 1 HORA.
-GLUCOMETRIA CADA 6 HORAS
-CUIDADOS DE HERIDAS POR ENFERMERÍA
-PREVENCIÓN DE CAÍDAS Y DE ZONAS DE PRESIÓN.
-ACOMPAÑANTE PERMANENTE.
-EDUCACIÓN A LA FAMILIA DEL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNA
-BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
-MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO

EN PROCESO
TAC DE CONTROL A LAS 13+00 HORAS
LECTURA DE TAC DE CRANEO, ORBITA , CERVICAL Y RX DE HOMBRO DERECHO

SE SOLICITA
VALORACIÓN POR CIRUGÍA PLÁSTICA Y MAXILOFACIAL

SEGUIMIENTO
NEUROCIRUGIA

METAS DE MONITOREO NEUROCRITICO
TAM DE 65-95 MG
GLUCOMETRIA 110 -180 MG/DL.
DIURESIS 0.5 A 1CC/KG/H EN PLAN DE BALANCE NEUTRO
EVA <4
SATURACIÓN >90%

GRACIAS!

2026-03-08 07:18	**PROFESIONAL:** fabchach - FABIAN ALEXIS CHANTRE GONZALEZ	**ESPECIALIDAD:** MEDICINA GENERAL

*** REPORTE DE PARACLINICOS ***

Orden Número: 202603080121
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-08 03:58

INR 1.06
TIEMPO DE PROTROMBINA 11.1
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 21.4

HEMATOCRITO 51.5
HEMOGLOBINA 17.1
RECUENTO DE LEUCOCITOS 23.47
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 224
NEUTROFILOS Abs 20.02
LINFOCITOS Abs 1.46
MONOCITOS Abs 1.36
EOSINOFILOS Abs 0.00
BASOFILOS Abs 0.02
NEUTROFILOS % 85.3
LINFOCITOS % 6.2
MONOCITOS % 5.8

EOSINOFILOS % 0.0
BASOFILOS % 0.1

TIEMPOS DE COAGULACION NORMALES
HEMOGRAMA CON HB NORMAL, LEUCOCITOSIS, SIN TROMBOCITOPENIA

2026-03-08 07:56	**PROFESIONAL:** marmulta - MARIA GISELL MURILLO TAMAYO	**ESPECIALIDAD:** FISIOTERAPIA

INGRESO UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

TERAPIA RESPIRATORIA NOCHE

PACIENTE SANTIAGO GARCIA GENERO MASCULINO DE 15 AÑOS DE EDAD , PACIENTE QUIEN INGRESA EN COMPAÑIA DE LA MADRE Y PERSONAL PARAMÉDICO POR PRESENTAR TRAUMA EN CRANEO Y HOMBRO DERECHO DURANTE ACCIDENTE DE TRANSITO DE ALTA CINEMÁTICA, LESIONES EN CARA Y MIEMBROS, REFIERE DOLOR A LOS ARCOS DE MOVIMIENTO DEL HOMBRO DERECHO Y CEFALEA, NIEGA PERDIDA DEL CONOCIMIENTO, EMESIS, CONVULSIONES U OTROS SIGNOS DE ALARMA NEUROLÓGICOS, NIEGA DIFICULTAD RESPIRATORIA U OTRO SIGNO DE ALARMA. AL INGRESO DESCRIBEN HEMATOMA Y HERIDA COMPLEJA FRONTAL DERECHA EQUIMOSIS PERIORBITARIA Y EDEMA PALPEBRAL DERECHO LEVE ABRASIÓN POMULO , GLASGOW 15/15, EN EL MOMENTO PACIENTE HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE, SIN SIGNOS DE BAJO GAST, FRECUENCIA CARDIACA Y TENSIONES ARTERIALES EN METAS, REQUIERE MONITOREO UCIN DADO RIESGO DE DETERIOR NEUROLÓGICO,HEMODINÁMICO . SE EXPLICA A LA MADRE QUIEN ENTIENDE Y ACEPTA.

DIAGNOSTICOS
POLITRAUMATISMO POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO
TRAUMA CRANEO ENCEFALICO LEVE CON RIESGO MODERADO POR CINEMATICA DEL TRAUMA
-NEUMOENCÉFALO
TRAUMA FACIAL
SOSPECHA FRACTURA SENO FRONTAL DERECHO
SOSPECHA FRACTURA DE PISO DE LA ORBITA
HERIDA FRONTAL DERECHA COMPLEJA
TRAUMA EN HOMBRO DERECHO

SIGNOS VITALES DE INGRESO

PRESIÓN ARTERIAL: 118/51 MMHG (71 MMHG)
FRECUENCIA CARDIACA: 89 LPM
FRECUENCIA RESPIRATORIA 18 RXM
SATURACION DE O297 %
TEMPERATURA 36.5 °C

EVALUACION POR SISTEMAS

- HEMODINAMICO: SIN SOPORTE VASAOCTIVO, SIN SIGNOS DE BAJO GASTO, NO FRIALDAD DISTAL, LLENADO CAPILAR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS SIMETRICOS REGULARES, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS
- RESPIRATORIO: TORAX SIMETRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO,
- GASTROINTESTINAL: ABDOMEN NO DISTENDIDO, BLANDO, DEPRESIBLE, SIN LLANTO A LA PALPACION, NO IRRITACION PERITONEAL.
- RENAL: MICCION ESPONTANEA, ORINA CLARA, NO EDEMAS.
- METABOLICO: TOLERANDO VIA ORAL, NO EMESIS, GLUCOMETRIA 108 MG/DL
- HEMATOLOGICO: NO SANGRADO, NO HEMATOMAS
- INFECCIOSO: NO PICOS FEBRILES
- NEUROLOGICO: ALERTA, ACTIVO, REACTIVO, SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE
-PIEL: HERIDA COMPLEJA FRONTAL DERECHO CON BORDES IRREGULARES DE PAROXIDAMENTE 4*4 CM , CON DEPRESION EN ZONA , NO SANGRADO ACTIVO. EDEMA Y EQUIMOSIS PALPEBRAL ASOCIADA

OBJETIVOS:
FAVORECER LA REEXPANSION PULMONAR
GARANTIZAR INTERCAMBIO GASEOSO

INTERVENCIÓN TERAPEUTICA

--MONITORIA RESPIRATORIA
--POSICIONAMIENTO EN CAMA EN SEMIFOWLER A 45°
--FISIOTERAPIA RESPIRARTORIA CON MOVILIZACIÓN DE REJA COSTAL
--ACELERACIÓN DE FLUJO ESPIRATORIO LENTO COMO TECNICA DE DESOBTRUCCION BRONQUIAL SIN MOVILIZAR SECRECIONES
--EJERCICIOS DE REEXPANSION PULMONAR CON INSPIRACIONES PROFUNDAS SOSTENIDAS 3 SERIES / 10 REPETICIONES
--INSPIRACIONES FRACCIONADAS Y SUSPIROS PROFUNDOS 3 SERIES / 10 REPETICIONES
-- EJERCICIOS INSPIRACIONES SOSTENIDAS, CON EXPIRACIONES FRACCIONADAS 3 SERIES / 10 REPETICIONES

PACIENTE TOLERA INTERVENCION, QUEDA ESTABLE DENTRO DE SU CUADRO CLÍNICO.

2026-03-08 08:21	**PROFESIONAL:** josordca - JORGE ALBERTO ORDONEZ CASTILLO	**ESPECIALIDAD:** NEUROCIRUGIA

NEUROCIRUGIA

PACIENTE CON POLITRAUMA POR ACCIDENTE DE TRANSITO, QUE INGRESA SIN FOCALIZACION NEUROLOGICA, SIN SIGNOS CLINICOS DE HIPERTENSION INTRACRANEANA, GLASGOW 15/15, CON TC DE CRANEO SIMPLE DE INGRESO QUE EVIDENCIA FRACTURA DE PARED POSTERIOR DE SENO AEREO FRONTAL DERECHO, NO EVIDENICAO FRACTURA DE PARED ANTERIOR, CON PEQUEÑO NEUMOENECFALO, SIN LESIONES INTRACRANEALES, SE INDICA VIGILANCIA EN UCIN CON ANALGESIA Y TAC DE CRANEO SIMPLE DE CONTROL 12 HORAS POSTERIOR A PRIMERA IAMGEN, SI NO HAY AUMENTO DE NEUMOENCEFALO NI CRECIMIENTO DE LESIONES QUE REQUIERAN MANEJO QUIRURGICO, SE PUEDE TRASLADAR A PISO Y DAR EGRESO, POR AHORA ANALGESIA Y VIGILANCIA DE FISTULA DE LCR, VIGILANCIA NEUROLOGICA

2026-03-08 10:56	**PROFESIONAL:** josnarba - JOSE GERMAN NARVAEZ BASTIDAS	**ESPECIALIDAD:** PEDIATRIA

EVOLUCION UCIP-DIA

NOMBRE: SANTIAGO GARCIA PAPAMIJA

EDAD: 15 AÑOS
DOCUMENTO: 1109922924
ENTIDAD: SOAT
ACUDIENTE: MADRE
FECHA DE INGRESO A URGENCIAS: 07/03/2026
FECHA DE INGRESO UCI: 08/03/2026

*ESTANCIA: CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRICO.
*CRITERIOS DE ESTANCIA: RIESGO DE HIPERTENSION ENDOCRANEANA.

*DIAGNOSTICOS:
POLITRAUMATISMO POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO
TRAUMA CRANEO ENCEFALICO LEVE CON RIESGO MODERADO POR CINEMATICA DEL TRAUMA
NEUMOENCÉFALO PEQUEÑO FRONTAL DERECHO
FRACTURA DE LA PARED POSTERIOR DEL SENO FRONTAL DERECHO
HERIDA FRONTAL DERECHA COMPLEJA
TRAUMA EN HOMBRO DERECHO

*SUBJETIVO: SANTIAGO MANIFIESTA TENER SENSACION DE MAREO Y DOLOR LEVE. PERMANECE AFEBRIL. TOLERA LA VIA ORAL.

*OBJETIVO:
FC: 86/MIN. TA: 118/63/68. FR: 16/MIN. SO2: 95% CON FIO2 DEL 21%. T: 36.5 °C. GLUCOMETRIA: 108 MG/DL.
CRANEO: NORMOCEFALO, HERIDA FRONTAL DERECHA CUBIERTA CON APOSITO DE GASAS. EQUIMOSIS EN REGION PERIORBITARIA DERECHA.
NEUROLOGICO: ALERTA, PUPILAS A 3 MM REACTIVAS, MOVIMIENTOS OCULARES NORMALES. SIN SIGNOS DE HIPERTENSION ENDOCRANEANA, MENINGEOS NI DE FOCALIZACION.
ORL: SIN ALETEO NASAL NI ESTRIDOR. SIN ESCURRIMIENTO POSTERIOR, RINOLIQUIA NI OTOLIQUIA. EQUIMOSIS EN PABELLON AURICULAR DERECHO.
CUELLO: LLENADO YUGULAR NORMAL. SI MASAS. MOVIL E INDOLOR.
TORAX: EUPNEICO, EXPANSIBILIDAD SIMETRICA, SIN RETRACCIONES.
PULMONES: MURMULLO VESICULAR NORMAL. SIN AGREGADOS.
CARDIOVASCULAR: EUCARDICO, EN SINUSAL, SIN SOPLOS, PULSOS NORMALES, LL. CAPILAR <2S, NORMOTENSO, EUTERMICO.
ABDOMEN: PERISTALTISMO NORMAL, BLANDO, INDOLORO. SIN DISTENSION, ASCITIS, MASAS NI MEGALIAS.
RENAL: HIDRATADO, EUVOLEMICO, SIN EDEMA. GASTO URINARIO EN CUANTIFICACION.
HEMATOLOGICO: SIN SANGRADO ACTIVO NI SIGNOS DE COAGULOPATIA.
INFECCIOSO: AFEBRIL, RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA REGULADA.
OSTEOMUSCULAR: SIN SIGNOS DE FRACTURAS DE HUESOS LARGOS.
PIEL: PEQUEÑA ESCORIACION EN POMULO DERECHO.

*ANALISIS: SANTIAGO SE VE TRANQUILO, ALERTA, AFEBRIL, HIDRATADO, EUVOLEMICO. EUPNEICO, SO2 NORMAL SIN OXIGENOTERAPIA. CON GASTO CARDIACO Y PERFUSION TISULAR NORMALES. SIN ABDOMEN AGUDO. CON FUNCION RENAL CONSERVADA. GASTO URINARIO NORMAL Y BALANCE HIDRICO EN PROCESO DE CUANTIFICACION. SIN COAGULOPATIA. RESPUESTA INFLAMATORIA REGULADA. SANTIAGO PERMANECE ESTABLE. SIN DETERIORO NEUROLOGICO, RESPIRATORIO NI CIRCULATORIO. CONTINUA EN OBSERVACION NEUROLOGICA. LE EXPLICO A LA MADRE EL ESTADO ACTUAL DE SALUD DEL NIÑO, RIESGOS Y PLAN DE MANEJO.

*PLAN TERAPEUTICO - UCIP
PESO 65 KG

-DIETA CORRIENTE.
-CABECERA A 45°
-AMPICILINA/SULBACTAM 3 G (CON BASE A AMPICILINA), C/6H, IV (FI: 08/03/2026).
-DIPIRONA 1 G, C/6H, IV.
-PARACETAMOL 1 G, C/6H, IV.
-HOJA NEUROLOGICA CADA 2 HORAS.
-SUSPENDER LEV Y DEJAR TAPON VENOSO.
-GLUCOMETRIA CADA 12 HORAS
-CUIDADOS DE HERIDAS POR ENFERMERÍA
-PREVENCIÓN DE CAÍDAS Y DE ZONAS DE PRESIÓN.
-ACOMPAÑANTE PERMANENTE.
-EDUCACIÓN A LA FAMILIA DEL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNA
-BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
-MONITORIA CONTINUA DE SIGNOS VITALES.
-CUANTIFICAR LIQUIDOS ADMINISTRADOS Y ELIMINADOS.
-EN PROCESO VALORACIÓN POR CIRUGÍA PLÁSTICA Y MAXILOFACIAL. TAC DE CRANEO SIMPLE DE CONTROL A LAS 13 HORAS
-SEGUIMIENTO POR NEUROCIRUGIA

*METAS TERAPEUTICAS:
-TAM DE 75-95 MMHG
-GLUCOMETRIA: 110 -180 MG/DL.
-DIURESIS 1-2 CC/KG/H.
-EVA: <4
-SO2: >94%.
JOSE GERMAN NARVAEZ B. PEDIATRA INTENSIVISTA. RM 52305/2000 - 76319436

2026-03-08 14:22	**PROFESIONAL:** nefbenma - NEFTALI JOAQUIN BENJUMEA MARULANDA	**ESPECIALIDAD:** CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL

CIRUGIA MAXILOFACIAL RESPUESTA INTERCONSULTA

PACIENTE MASCULINO INTERCONSULTADO POR TRAUMA FACIAL. PACIENTE POLITRAUMATIZADO.
CLINICAMENTE CONCIENTE, ALERTA, ORIENTADO, AL EXAMEN EXTRAORAL FACIAL HERIDA EN REGION FRONTAL IRREGULAR, AVULSIVA, ABRASON EN REGION MALAR DERECHA, EDEMA PERIORBITARIO DERECHO CON OCLUSION PALPEBRAL DEL 20%, EQUIMOSIS PERIORBITARIA DERECHA, MOVIMIENTOS OCULARES CONSERVADOS, AUSENCIA DE SIGNOS DE OFTALMOPLEJIA, ESTABILIDAD DE LA

PIRAMIDE NASAL, NO SE PALPA ESCALONES OSEOS PERIORBITARIOS, BUENA PROYECCION ORBITOMALAR BILATERAL, BUENA EXCURSCION CONDILAR MANDIBULAR BILATERAL, AL EXAMEN INTRAORAL APERTURA BUCAL SIN LIMITACIONES, OCLUSION ESTABLE, SIGNO DE PINZA DEL MAXILAR SUPERIOR NEGATIVO, INTEGRIDAD DEL PILAR MAXILOMALAR BILATERAL.
EN TOMOGRAFIA DE CARA SE OBSERVA FRACTURA DE LA PARED POSTERIOR DEL SENO FRONTAL LADO DERECHO, HEMOSENO MAXILAR IZQUIERDO CON FRACTURA DE LA PARED POSTEROLATERAL Y ANTERIOR DEL SENO MAXILAR IZQUIERDO NO DESPLAZADA. FRACTURA NO DESPLAZADA DEL PISO DE LA ORBITA DERECHA.

DX FACIAL:
1. TRAUMA FACIAL
2. FRACTURA PARED POSTERIOR DEL SENO FRONTAL DERECHO
3. FRACTURA NO DESPLAZADA DE LA PARED POSTERO-LATERAL Y ANTERIOR DEL SENO MAXILAR IZQUIERDO.
4. FRACTURA NO DESPLAZADA DEL PISO DE LA ORBITA DERECHA.
4. HERIDA FACIAL COMPLEJA.

PLAN:
PACIENTE NO TIENE INDICACION QUIRURGICA POR CIRUGIA MAXILOFACIAL.
FRACTURA DE MANEJO CONSERVADOR. INTERCONSULTAR A CIRUGIA PLASTICA PARA MANEJO DE HERIDA FACIAL.
SE CIERRA INTERCONSULTA.

2026-03-08 14:55	**PROFESIONAL:** josnarba - JOSE GERMAN NARVAEZ BASTIDAS	**ESPECIALIDAD:** PEDIATRIA

REPORTE DE IMAGENES
**ESTUDIO: TAC DE COLUMNA CERVICAL (TRES ESPACIOS + CUATRO ESPACIOS ADICIONALES)
NOMBRE: SANTIAGO GARCIA PAPAMIJA
DOCUMENTO: TI 1109922924 EDAD: 15 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-07
ENTIDAD: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA ENTIDAD COOPERATIVA
TÉCNICA:
En tomógrafo multidetector de se realizan cortes axiales finos en la región cervical desde C1 hasta C7 con posterior reconstrucciones multiplanares en estación de trabajo, observando:
HALLAZGOS:
Los cuerpos vertebrales y elementos posteriores son de patrón trabecular normal, sin identificarse lesiones líticas, blásticas ni trazos de fractura.
Las articulaciones facetarias y uncovertebrales se conservan. Los agujeros vertebrales tienen aspecto normal. Los espacios intervertebrales se encuentran conservados. La amplitud del canal medular y los neuroforámenes es normal, sin lesiones ocupantes de espacio, lesiones epi o subdurales. No hay trastornos de la alineación. Los tejidos blandos paravertebrales no presentan alteraciones.
OPINIÓN:
1. TOMOGRAFÍA DE COLUMNA CERVICAL DENTRO DE PARÁMETROS NORMALES.
Informe firmado electrónicamente por:
SANDRA ELIZABETH GIRALDO REYES
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 29927483
Fecha y hora de firma: 08-03-2026 11:19

**ESTUDIO: TAC DE CRANEO SIMPLE
NOMBRE: SANTIAGO GARCIA PAPAMIJA
DOCUMENTO: TI 1109922924 EDAD: 15 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-07
ENTIDAD:ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA ENTIDAD COOPERATIVA

TÉCNICA:
En tomógrafo multidetector y sin la aplicación de material de contraste se realizan cortes axiales desde la base del cráneo hasta el vértex con posteriores reconstrucciones multiplanares, observando:
HALLAZGOS:
Fractura deprimida de la pared posterior del seno frontal derecho con hemoseno secundario.
Hay también un pequeño foco de hemorragia subaracnoidea frontal adyacente al trazo de fractura.
La diferenciación de la sustancia gris y la sustancia blanca es adecuada.
La profundidad del espacio subaracnoideo es adecuada y guarda proporción con la amplitud del sistema ventricular.
No se identifican colecciones epi ni subdurales.
Lo visualizado del tallo y el cerebelo no presenta alteraciones.
Celdillas mastoideas no presentan alteraciones.
Hay hemoseno maxilar y esfenoidal izquierdos.
Fractura de rasgo oblicuo no desplazada del piso de la órbita derecha y la pared anterior del seno maxilar derecho, que se extiende medialmente, afectando el conducto nasolacrimal.
Se observa también fractura de la pared anterior del seno maxilar izquierdo con hemoseno secundario.
Edema de los tejidos blandos de la región frontal en el lado derecho.
OPINIÓN:
1. Pequeño foco de hemorragia subaracnoidea frontal derecha.
2. Fractura conminuta y deprimida de la pared posterior del seno frontal derecho.
3. Fractura de la pared anterior del seno maxilar izquierdo con hemoseno secundario.
4. Fractura del piso de la órbita derecha y la pared anterior del seno maxilar derecho, que se extiende medialmente, afectando el conducto nasolacrimal.

2026-03-08 22:01	**PROFESIONAL:** yurherri - YURY NATHALYA HERNANDEZ RINCON	**ESPECIALIDAD:** FISIOTERAPIA

NOTA FISIOTERAPIA TURNO NOCHE

SE INGRESA CON PREVIO LAVADO DE MANOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN PROTOCOLO INSTITUCIONAL.

PACIENTE MASCULINO DE 15 AÑO, POLITRAUMATISMO POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO, TRAUMA CRANEO ENCEFALICO LEVE CON RIESGO MODERADO POR CINEMATICA DEL TRAUMA, NEUMOENCÉFALO, TRAUMA FACIAL, SOSPECHA FRACTURA SENO FRONTAL DERECHO, SOSPECHA FRACTURA DE PISO DE LA ORBITA
HERIDA FRONTAL DERECHA COMPLEJA, TRAUMA EN HOMBRO DERECHO, AL MOMENTO SIN SEDOANALGESIA, ACTIVO, REACTIVO A ESTIMULOS, SIGUE ORDENES COMPLEJAS, ANSIOSO, GLASGOW 15/15, SIN SOPORTE VASO ACTIVO, CON SIGNOS VITALES: FRECUENCIA

CARDIACADA 74 LATIDOS POR MINUTO , FRECUENCIA RESPIRATORIA 19 ESPIRACIONES POR MINUTO, TENSION ARTERIAL: 112/58mmHG, SATURANDO 98%, AL MOMENTO SIN SOPORTE ADICIONAL DE OXIGENO, FIO2 21%, TÓRAX SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, A LA AUSCULTACION MURMULLO VESICULAR CONSERVADO SIN AGREGADOS, PATRON RESPIRATORIO COSTAL.

OBJETIVOS TERAPEUTICOS
* OXIMETRIAS >92%
* PREVENIR COMPLICACIONES RESPIRATORIAS
* MANTENER VIA AEREA PERMEABLE

INTERVENCION TERAPEUTICA
* DRENAJE POSTURAL, POSICIONAMIENTO EN CAMA A 30°
* KINESIOLOGIA DE TORAX CON LIMITACION A LA MOVILIADAD EN MSD+ AFE CON PATROS DE TOS NO PRODUCTIVO.
* CONCIENCIA DE PATRON RESPIATORIO
* VIGILANCIA RESPRATORIA.

SE FINALIZA SIN COMPLICACIONES INMEDIATAS, SE CONTINUA VIGILANCIA HEMODINAMICA Y RESPIRATORIA.

2026-03-08 23:56	**PROFESIONAL:** sebmonvi - SEBASTIAN MONTES VILLEGAS	**ESPECIALIDAD:** MEDICINA GENERAL

EVOLUCION UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS - PEDIATRICO - NOCHE RETROSPECTIVA, HORA ATENCION 21:00 H
DRA. DONNEYS (MD PEDIATRA) - DR. MONTES V. (MD ASISTENCIAL)

NOMBRE: SANTIAGO GARCIA PAPAMIJA
EDAD: 15 AÑOS
DOCUMENTO: 1109922924
ENTIDAD: SOAT
ACUDIENTE: MADRE - 3128845383
FECHA DE INGRESO A URGENCIAS: 07/03/2026
FECHA DE INGRESO UCI: 08/03/2026

* DIAGNOSTICOS
POLITRAUMATISMO POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO
TRAUMA CRANEOENCEFALICO MODERADO
-NEUMOENCÉFALO FRONTAL DERECHO
-PEQUEÑO FOCO DE CONTUSIÓN HEMORRÁGICA FRONTAL DERECHA
TRAUMA FACIAL
-FRACTURA PARED POSTERIOR DEL SENO FRONTAL DERECHO
-FRACTURA NO DESPLAZADA DE LA PARED POSTERO-LATERAL Y ANTERIOR DEL SENO MAXILAR IZQUIERDO.
-FRACTURA NO DESPLAZADA DEL PISO DE LA ORBITA DERECHA.
-HERIDA COMPLEJA PROFUNDA FRONTAL DERECHA
TRAUMA EN HOMBRO DERECHO
-FRACTURA DE TERCIO DISTAL DE LA CLAVÍCULA

* CRITERIOS UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS PEDIATRICO
.- MONITORIA RESPIRATORIA, HEMODINÁMICA CONTINUO NO INVASIVO
.- MONITOREO NEUROCRITICO CONTINUO

* INVASIONES
- CATETER VENOSO PERIFERICO MSI - FI 07/03/2026

* SOPORTES
- NINGUNO

* SUBJETIVO: EN COMPAÑIA DE LA MADRE, SANTIAGO REFIERE DOLOR DE INTENSIDAD 4/10 SEGUN EVA A NIVEL DE HOMBRO DERECHO QUE EMPEORA CON LA MOVILIDAD, REFIERE MEJORIA DEL DOLOR A NIVEL FACIAL, NIEGA OTRA SINTOMATOLOGIA.

* OBJETIVO: EN CAMA, EN ACEPTABLE CONDICIÓN GENERAL, ALERTA, CONSCIENTE, ORIENTADO GLOBALMENTE, HIDRATADO, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA.

SIGNOS VITALES:
PRESIÓN ARTERIAL: 125/62 MMHG (PAM 8. MMHG)
FRECUENCIA CARDIACA: 62 LATIDOS/MINUTO
FRECUENCIA RESPIRATORIA 16 RESPIRACIONES/MINUTO
SATURACIÓN DE O2 97% FiO2 0.21%
TEMPERATURA 36.2 °C

PESO 65 KG - TALLA 165 CM

BALANCE HÍDRICO EN 12 HORAS:
LIQUIDOS ADMINISTRADOS: 1560 CC
LIQUIDOS ELIMINADOS: 950 CC
BALANCE DIA: + 610 CC
BALANCE ANTERIOR: + 320 CC
GU: 1.2 CC/KG/H

CABEZA Y ORL: ESCLERAS ANICTERICAS, MUCOSAS HUMEDAS, CONJUNTIVAS ROSADAS.
- HEMODINAMICO: SIN SOPORTE VASAOCTIVO, SIN SIGNOS DE BAJO GASTO, NO FRIALDAD DISTAL, LLENADO CAPILAR MENOR DE 3 SEGUNDOS, PULSOS SIMETRICOS REGULARES, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS
- RESPIRATORIO: TORAX SIMETRICO, NORMOEXPANSIBLE, SIN TIRAJES, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO, SIN SOBREAGREGADOS.

- GASTROINTESTINAL: ABDOMEN NO DISTENDIDO, BLANDO, DEPRESIBLE, SIN LLANTO A LA PALPACION, NO IRRITACION PERITONEAL.
- RENAL: MICCION ESPONTANEA, ORINA CLARA, NO EDEMAS.
- METABOLICO: TOLERANDO LAL VIA ORAL, NO EMESIS, GLUCOMETRIA 92 MG/DL
- HEMATOLOGICO: NO SANGRADO, NO HEMATOMAS
- INFECCIOSO: SIN DISTERMIAS, AFEBRIL.
- OSTEOMUSCULAR: HOMBRO DERECHO: EDEMA, CREPITACION, DOLOR A LA PALPACION, ARCOS DE MOVILIDAD ARTICULAR LIMITADOS, NO DEFICIT NEUROVASCULAR DISTAL, LLENADO CAPILAR MENOR DE 3 SEGUNDOS. RESTO DE EXTREMIDADES SIMETRICAS, MOVILES Y SIN EDEMAS.
- NEUROLOGICO: ALERTA, ACTIVO, REACTIVO, SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE
-PIEL: HERIDA COMPLEJA PROFUNDA EN REGION FRONTAL DERECHA CON BORDES IRREGULARES AVULSIVOS, TIENE CURACION, HAY EDEMA Y EQUIMOSIS PALPEBRAL ASOCIADA.

ANTIBIÓTICO
-AMPICILINA/SULBACTAM (FI: 08/03/2026). - ACTIVO

* ANALISIS
PACIENTE DE 15 AÑOS, POLITRAUMATISMO POR ACCIDENTE DE TRANSITO, AHORA CON LA SIGUIENTE CONDICIÓN CLÍNICA:

- TRAUMA CRANEOENCEFALICO MODERADO CON TAC DE CRANEO QUE EVIDENCIA NEUMOENCÉFALO PEQUEÑO A NIVEL FRONTAL CON CONTUSIÓN HEMORRÁGICA ASOCIADA, SIN EDEMA CEREBRAL, LINEA MEDIA CENTRADA, NO LESIONES OCUPANTES DE ESPACIO, SIN CRITERIO DE MANEJO QUIRÚRGICO POR NEUROCIRUGIA, DR. ORDOÑEZ, SE ESTABLECE MONITORIA CONTINUA EN UCIN Y SE REALIZA TAC DE CRANEO DE CONTROL TRAS 12 H SIN EVIDENCIA DE AUMENTO DE LESIONES YA CONOCIDAS, SE COMENTAN HALLAZGOS CON ESPECIALIDAD INTERCONSULTANTE, EN PROCESO DE CONCEPTO OFICIAL. ACTUALMENTE SIN DETERIORO NEUROLÓGICO, SIN CEFALEA, TOLERANDO LA VIA ORAL, SIN SIGNOS DE HIPERTENSIÓN ENDOCRANEANA. CONTINUA MONITORIA ESTRICTA.

- TRAUMA FACIAL CON TAC DE CARA QUE EVIDENCIA FRACTURA PARED POSTERIOR DEL SENO FRONTAL DERECHO, FRACTURA NO DESPLAZADA DE LA PARED POSTERO-LATERAL Y ANTERIOR DEL SENO MAXILAR IZQUIERDO, FRACTURA NO DESPLAZADA DEL PISO DE LA ORBITA DERECHA, CON HERIDA COMPLEJA PROFUNDA FRONTAL YA DESCRITA, SE REALIZA INTERCONSULTA POR CX MAXILOFACIAL, DR. BENJUMEA, INDICA MANEJO CONSERVADOR; EN CONTEXTO DE LA HERIDA EN CUBRIMIENTO ANTIBIÓTICO CON AMPICILINA SULBACTAM, SE INTERCONSULTA POR CX PLASTICA, QUIEN INDICA MANEJO DE TEJIDOS BLANDOS, EN PROCESO.

- TRAUMA EN HOMBRO DERECHO CON RADIOGRAFÍA DE HOMBRO QUE EVIDENCIA FRACTURA DE TERCIO DISTAL DE CLAVÍCULA DERECHA, SE SOLICITA INTERCONSULTA POR ORTOPEDIA INFANTIL, SE COMENTA HALLAZGOS CON DR. PRADO, QUIEN INDICA MANEJO CONSERVADOR, USO DE INMOVILIZADOR DE HOMBRO Y CONTROL AMBULATORIO POR LA ESPECIALIDAD, INCAPACIDAD MEDICA POR 30 DIAS. SE CONTINUA ANALGESIA.

ACTUALMENTE VARIABLES MACROHEMODINAMICAS EN RANGOS DE NORMALIDAD, SIN SIGNOS DE BAJO GASTO CARDIACO, SIN DETERIORO NEUROLOGICO, TOLERANDO LA VIA ORAL, SE CONTINUA MONITORIA NEUROCRITICA EN CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO ESTRICTA CONTINUA, SE EXPLICA EL ESTADO ACTUAL Y PLAN DE MANEJO A SEGUIR A LA MADRE, QUIEN ENTIENDE Y ACEPTA.

2026-03-09 01:15	**PROFESIONAL:** sebmonvi - SEBASTIAN MONTES VILLEGAS	**ESPECIALIDAD:** MEDICINA GENERAL

REPORTE DE IMAGENES

RADIOGRAFIA DE HOMBRO DERECHO 2026-03-07 23:51 H**********PENDIENTE REPORTE OFICIAL--- COMO OPINION PERSONAL: SE EVIDENCIA FRACTURA DE TERCIO DISTAL DE CLAVICULA DERECHA, DE MANEJO CONSERVADOR POR ORTOPEDIA INFANTIL, DR. PRADO. YA CON INMOVILIZADOR DE HOMBRO.

ESTUDIO: TAC DE CRANEO SIMPLE CONTROL
NOMBRE: SANTIAGO GARCIA PAPAMIJA
DOCUMENTO: TI 1109922924 EDAD: 15 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-08 13:55 H
ENTIDAD:
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
LTDA ENTIDAD COOPERATIVA
TÉCNICA:
Se realizaron cortes axiales desde la base hasta el vértex con registro para tejidos blandos y ventana ósea.
HALLAZGOS:
Línea media central.
Diferenciación de sustancia gris sustancia blanca conservada.
No hay colecciones intra o extra-axiales postraumáticas recientes.
Sistema ventricular de tamaño y configuración normal.
Lo visualizado de fosa posterior, tallo, órbitas y cavidades paranasales no muestra alteración.
No identifico fracturas desplazadas o deprimidas de la bóveda craneana.
Informe firmado electrónicamente por:
RUBEN DAVID GOMEZ ARDILA
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 052566/2008
Fecha y hora de firma: 08-03-2026 21:54

ESTUDIO: TAC DE CRANEO SIMPLE INGRESO
NOMBRE: SANTIAGO GARCIA PAPAMIJA
DOCUMENTO: TI 1109922924 EDAD: 15 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-07 01:11 H
ENTIDAD:
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
LTDA ENTIDAD COOPERATIVA
DLP 1627.72 mGy.cm.
TÉCNICA:
En tomógrafo multidetector y sin la aplicación de material de contraste se realizan cortes axiales desde la base del cráneo
hasta el vértex con posteriores reconstrucciones multiplanares, observando:

HALLAZGOS:
Fractura deprimida de la pared posterior del seno frontal derecho con hemoseno secundario.
Hay también un pequeño foco de hemorragia subaracnoidea frontal adyacente al trazo de fractura.
La diferenciación de la sustancia gris y la sustancia blanca es adecuada.
La profundidad del espacio subaracnoideo es adecuada y guarda proporción con la amplitud del sistema ventricular.
No se identifican colecciones epi ni subdurales.
Lo visualizado del tallo y el cerebelo no presenta alteraciones.
Celdillas mastoideas no presentan alteraciones.
Hay hemoseno maxilar y esfenoidal izquierdos.
Fractura de rasgo oblicuo no desplazada del piso de la órbita derecha y la pared anterior del seno maxilar derecho, que se extiende medialmente, afectando el conducto nasolacrimal.
Se observa también fractura de la pared anterior del seno maxilar izquierdo con hemoseno secundario.
Edema de los tejidos blandos de la región frontal en el lado derecho.
OPINIÓN:
1. Pequeño foco de hemorragia subaracnoidea frontal derecha.
2. Fractura conminuta y deprimida de la pared posterior del seno frontal derecho.
3. Fractura de la pared anterior del seno maxilar izquierdo con hemoseno secundario.
4. Fractura del piso de la órbita derecha y la pared anterior del seno maxilar derecho, que se extiende medialmente, afectando el conducto nasolacrimal.
Informe firmado electrónicamente por:
SANDRA ELIZABETH GIRALDO REYES
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 29927483
Fecha y hora de firma: 08-03-2026 13:48

TAC DE COLUMNA CERVICAL
ESTUDIO: TAC DE COLUMNA CERVICAL (TRES ESPACIOS + CUATRO ESPACIOS ADICIONALES)
NOMBRE: SANTIAGO GARCIA PAPAMIJA
DOCUMENTO: TI 1109922924 EDAD: 15 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-07 01:11 H
ENTIDAD:
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
LTDA ENTIDAD COOPERATIVA
DLP 1627.72 mGy.cm
TÉCNICA:
En tomógrafo multidetector de se realizan cortes axiales finos en la región cervical desde C1 hasta C7 con posterior reconstrucciones multiplanares en estación de trabajo, observando:
HALLAZGOS:
Los cuerpos vertebrales y elementos posteriores son de patrón trabecular normal, sin identificarse lesiones líticas, blásticas ni trazos de fractura.
Las articulaciones facetarias y uncovertebrales se conservan.
Los agujeros vertebrales tienen aspecto normal.
Los espacios intervertebrales se encuentran conservados.
La amplitud del canal medular y los neuroforámenes es normal, sin lesiones ocupantes de espacio, lesiones epi o subdurales.
No hay trastornos de la alineación.
Los tejidos blandos paravertebrales no presentan alteraciones.
OPINIÓN:
1. TOMOGRAFÍA DE COLUMNA CERVICAL DENTRO DE PARÁMETROS NORMALES.
Informe firmado electrónicamente por:
SANDRA ELIZABETH GIRALDO REYES
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 29927483
Fecha y hora de firma: 08-03-2026 11:19

ESTUDIO: TAC DE ORBITAS
NOMBRE: SANTIAGO GARCIA PAPAMIJA
DOCUMENTO: TI 1109922924 EDAD: 15 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-07 11:30 H
ENTIDAD:
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
LTDA ENTIDAD COOPERATIVA
TÉCNICA:
En tomógrafo multidetector, se realizan cortes axiales y coronales de 3 y 5mm. En región orbitaria, posteriormente se realizan reconstrucciones coronales y sagitales.
HALLAZGOS:
Fractura que compromete la pared medial de la órbita derecha con desplazamiento de fragmentos óseos.
Globos oculares de aspecto normal.
Planos musculares y espacio intra y extraconal sin alteraciones.
Fractura que compromete la pared posterior del seno frontal derecho con ocupación con material con densidad de tejidos blandos.
Ocupación con material con densidad de tejidos blandos en los senos paranasales de predominio en el seno esfenoidal, celdillas etmoidales y seno maxilar izquierdo.
Septo nasal central.
Cambios inflamatorios en los tejidos blandos.
Hematoma subgaleal frontal derecho.
CONCLUSIÓN:
1. Fractura de la pared medial de la órbita derecha.
2. Fractura del seno esfenoidal derecho en su pared posterior.

3. Hemoseno.
nforme firmado electrónicamente por:
RUBEN DAVID GOMEZ ARDILA
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 052566/2008
Fecha y hora de firma: 08-03-2026 21:05

2026-03-09 01:17	**PROFESIONAL:** sebmonvi - SEBASTIAN MONTES VILLEGAS	**ESPECIALIDAD:** MEDICINA GENERAL

REPORTE DE PARACLINICOS

DE ORDEN 202603080121
Fecha y Hora de ingreso: 2026-03-08, 03:58

INR 1.06
TIEMPO DE PROTROMBINA 11.1 seg
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 21.4 seg
TIEMPOS DE COAGULACION NORMALES

RECUENTO DE ERITROCITOS 5.60 X10*6/mm³
MCV 92.0 um3
MCH 30.6 pg
MCHC 33.2 g/dl
INDICE DE DISTRIBUCION PLAQUETARIA 16.2 %
RDW SD 46.7 um3
RDW CV 13.6 %
MPV 11.6 um3
NEUTROFILOS Abs 20.02
LINFOCITOS Abs 1.46
MONOCITOS Abs 1.36
EOSINOFILOS Abs 0.00
BASOFILOS Abs 0.02
NEUTROFILOS % 85.3 %
LINFOCITOS % 6.2 %
MONOCITOS % 5.8 %
EOSINOFILOS % 0.0 %
BASOFILOS % 0.1 %
HEMATOCRITO 51.5 %
HEMOGLOBINA 17.1 g/dl
RECUENTO DE LEUCOCITOS 23.47 X10³/mm³
RECUENTO TOTAL DE PLAQUETAS 224 X10³/mm³
CONTEO PLAQUETARIO NORMAL, LEUCOCITOSIS CON NEUTROFILIA POR TRAUMA, SIN ANEMIA, HEMATOCRITO EN LIMITE SUPERIOR NORMAL.

2026-03-09 12:27	**PROFESIONAL:** fraquipo - FRANCISCO JAVIER QUINTERO PORTILLA	**ESPECIALIDAD:** MEDICINA GENERAL

EVOLUCION UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS - PEDIATRICO - DIA -
DR. MILTON MOLANO (MD ESPECIALISITA) - FRANCISCO QUINTERO P (MD ASISTENCIAL)

NOMBRE: SANTIAGO GARCIA PAPAMIJA
EDAD: 15 AÑOS
DOCUMENTO: 1109922924
ENTIDAD: SOAT
ACUDIENTE: MADRE - 3128845383
FECHA DE INGRESO A URGENCIAS: 07/03/2026
FECHA DE INGRESO UCI: 08/03/2026

* DIAGNOSTICOS
POLITRAUMATISMO POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO
TRAUMA CRANEOENCEFALICO MODERADO
-NEUMOENCÉFALO FRONTAL DERECHO
-PEQUEÑO FOCO DE CONTUSIÓN HEMORRÁGICA FRONTAL DERECHA
TRAUMA FACIAL
-FRACTURA PARED POSTERIOR DEL SENO FRONTAL DERECHO
-FRACTURA NO DESPLAZADA DE LA PARED POSTERO-LATERAL Y ANTERIOR DEL SENO MAXILAR IZQUIERDO.
-FRACTURA NO DESPLAZADA DEL PISO DE LA ORBITA DERECHA.
-HERIDA COMPLEJA PROFUNDA FRONTAL DERECHA
TRAUMA EN HOMBRO DERECHO
-FRACTURA DE TERCIO DISTAL DE LA CLAVÍCULA

* CRITERIOS UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS PEDIATRICO
.- MONITORIA RESPIRATORIA, HEMODINÁMICA CONTINUO NO INVASIVO
.- MONITOREO NEUROCRITICO CONTINUO

* INVASIONES
- CATETER VENOSO PERIFERICO MSI - FI 07/03/2026

* SOPORTES
- NINGUNO

* SUBJETIVO: PACIENTE EN CAMA REFIERE QUE PASA BUENA NOCHE, LOGRA ADECUADA CONCILIACION DE SUEÑO, DOLOR MODULADO.

* OBJETIVO:PACIENTE EN CAMA EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES DE MOMENTO SIN REQUERIR NINGÚN TIPO DE SOPORTE, SIN SIGNOS DE FOCALIZACIÓN NEUROLÓGICA.

SIGNOS VITALES:
PRESIÓN ARTERIAL: 116/71 MMHG (PAM 86 MMHG)
FRECUENCIA CARDIACA: 69 LATIDOS/MINUTO
FRECUENCIA RESPIRATORIA 17 RESPIRACIONES/MINUTO
SATURACIÓN DE O2 97% FiO2 0.21%
TEMPERATURA 36.6 °C

PESO 65 KG - TALLA 165 CM

BALANCE HÍDRICO EN 24 HORAS:
LIQUIDOS ADMINISTRADOS: 2360 CC
LIQUIDOS ELIMINADOS: 1350 CC
BALANCE DIA: + 1010 CC
BALANCE ANTERIOR: 320 + CC
GU: 0.8 CC/KG/H

CABEZA Y ORL: HERIDA EN REGIN FRONTAL CUBIERTA CON APOSTIO ESTERIL SIN ESTIGMAS DE SANGRADO, OREJA DERECHA CON HEMATOMA, ESCLERAS ANICTERICAS, MUCOSAS HUMEDAS, CONJUNTIVAS ROSADAS.
- HEMODINAMICO: SIN SOPORTE VASAOCTIVO, SIN SIGNOS DE BAJO GASTO, NO FRIALDAD DISTAL, LLENADO CAPILAR MENOR DE 3 SEGUNDOS, PULSOS SIMETRICOS REGULARES, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS
- RESPIRATORIO: TORAX SIMETRICO, NORMOEXPANSIBLE, SIN TIRAJES, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO, SIN SOBREAGREGADOS.
- GASTROINTESTINAL: ABDOMEN NO DISTENDIDO, BLANDO, DEPRESIBLE, SIN LLANTO A LA PALPACION, NO IRRITACION PERITONEAL.
- RENAL: MICCION ESPONTANEA, ORINA CLARA, NO EDEMAS.
- METABOLICO: TOLERANDO LAL VIA ORAL, NO EMESIS, GLUCOMETRIA 92 MG/DL
- HEMATOLOGICO: NO SANGRADO, NO HEMATOMAS
- INFECCIOSO: SIN DISTERMIAS, AFEBRIL.
- OSTEOMUSCULAR: HOMBRO DERECHO: EDEMA, CREPITACION, DOLOR A LA PALPACION, ARCOS DE MOVILIDAD ARTICULAR LIMITADOS, NO DEFICIT NEUROVASCULAR DISTAL, LLENADO CAPILAR MENOR DE 3 SEGUNDOS. RESTO DE EXTREMIDADES SIMETRICAS, MOVILES Y SIN EDEMAS.
- NEUROLOGICO: ALERTA, ACTIVO, REACTIVO, SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE
-PIEL: HERIDA COMPLEJA PROFUNDA EN REGION FRONTAL DERECHA CON BORDES IRREGULARES AVULSIVOS, TIENE CURACION, HAY EDEMA Y EQUIMOSIS PALPEBRAL ASOCIADA.

ANTIBIÓTICO
-AMPICILINA/SULBACTAM (FI: 08/03/2026). - ACTIVO

* ANALISIS

PACIENTE DE 15 AÑOS, POLITRAUMATISMO POR ACCIDENTE DE TRANSITO, AHORA CON LA SIGUIENTE CONDICIÓN CLÍNICA:

- TRAUMA CRANEOENCEFALICO MODERADO CON TAC DE CRANEO QUE EVIDENCIA NEUMOENCÉFALO PEQUEÑO A NIVEL FRONTAL CON CONTUSIÓN HEMORRÁGICA ASOCIADA, SIN EDEMA CEREBRAL, LINEA MEDIA CENTRADA, NO LESIONES OCUPANTES DE ESPACIO, SIN CRITERIO DE MANEJO QUIRÚRGICO POR NEUROCIRUGIA, DR. ORDOÑEZ, SE ESTABLECE MONITORIA CONTINUA EN UCIN Y SE REALIZA TAC DE CRANEO DE CONTROL TRAS 12 H SIN EVIDENCIA DE AUMENTO DE LESIONES YA CONOCIDAS, SE COMENTAN HALLAZGOS CON ESPECIALIDAD INTERCONSULTANTE, EN ESPERA DE CONCEPTO OFICIAL. ACTUALMENTE SIN DETERIORO NEUROLÓGICO, SIN CEFALEA, TOLERANDO LA VIA ORAL, SIN SIGNOS DE HIPERTENSIÓN ENDOCRANEANA. CONTINUA MONITORIA ESTRICTA.

- TRAUMA FACIAL CON TAC DE CARA QUE EVIDENCIA FRACTURA PARED POSTERIOR DEL SENO FRONTAL DERECHO, FRACTURA NO DESPLAZADA DE LA PARED POSTERO-LATERAL Y ANTERIOR DEL SENO MAXILAR IZQUIERDO, FRACTURA NO DESPLAZADA DEL PISO DE LA ORBITA DERECHA, CON HERIDA COMPLEJA PROFUNDA FRONTAL YA DESCRITA, HALLAZGO COMENTADO CON EL SERVICIO DE CIRUGÍA MAXILOFACIAL (DR BENJUMEA) QUIEN CONSIDERA DAR MANEJO CONSERVADOR, CURSA ADEMÁS CON HERIDA EN REGION FRONTAL EN ESPERA DE SER INTERVENIDA POR EL SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA.
PRESENTA HEMATOMA EN OREJA DERCHA SE COMENTARA CON CIRUGIA PLASTICA PARA DETERMINAR SI REQUIERE ALGUN TIPO DE MANEJO.

- TRAUMA EN HOMBRO DERECHO CON RADIOGRAFÍA DE HOMBRO QUE EVIDENCIA FRACTURA DE TERCIO DISTAL DE CLAVÍCULA DERECHA, SE SOLICITA INTERCONSULTA POR ORTOPEDIA INFANTIL, SE COMENTA HALLAZGOS CON DR. PRADO, QUIEN INDICA MANEJO CONSERVADOR, USO DE INMOVILIZADOR DE HOMBRO Y CONTROL AMBULATORIO POR LA ESPECIALIDAD, INCAPACIDAD MEDICA POR 30 DIAS. SE CONTINUA ANALGESIA.

ACTUALMENTE VARIABLES MACROHEMODINAMICAS EN RANGOS DE NORMALIDAD, SIN SIGNOS DE BAJO GASTO CARDIACO, SIN DETERIORO NEUROLOGICO, TOLERANDO LA VIA ORAL, SE CONTINUA MONITORIA NEUROCRITICA EN CUIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO ESTRICTA CONTINUA, SE EXPLICA EL ESTADO ACTUAL Y PLAN DE MANEJO A SEGUIR A LA MADRE, QUIEN ENTIENDE Y ACEPTA.

2026-03-09 13:56	**PROFESIONAL:** fraquipo - FRANCISCO JAVIER QUINTERO PORTILLA	**ESPECIALIDAD:** MEDICINA GENERAL

** REPORTE DE IMAGENES **

ESTUDIO: RADIOGRAFIA DE HOMBRO DERECHO
NOMBRE: SANTIAGO GARCIA PAPAMIJA
DOCUMENTO: TI 1109922924 EDAD: 15 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-07
ENTIDAD:
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
LTDA ENTIDAD COOPERATIVA

DLP 0.736 mGy.cm
Se obtiene proyección AP en rotación interna y rotación externa observando:
HALLAZGOS:
Fractura conminuta del tercio distal de la clavícula no desplazada.
Las relaciones articulares se encuentran conservadas.
Edema de los tejidos blandos.

No se observan lesiones líticas ni blásticas.

Informe firmado electrónicamente por:
SANDRA ELIZABETH GIRALDO REYES
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 29927483
Fecha y hora de firma: 09-03-2026 10:13

ESTUDIO: TAC DE CRANEO SIMPLE CONTROL
NOMBRE: SANTIAGO GARCIA PAPAMIJA
DOCUMENTO: TI 1109922924 EDAD: 15 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-08 13:55 H
ENTIDAD:
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
LTDA ENTIDAD COOPERATIVA
TÉCNICA:
Se realizaron cortes axiales desde la base hasta el vértex con registro para tejidos blandos y ventana ósea.
HALLAZGOS:
Línea media central.
Diferenciación de sustancia gris sustancia blanca conservada.
No hay colecciones intra o extra-axiales postraumáticas recientes.
Sistema ventricular de tamaño y configuración normal.
Lo visualizado de fosa posterior, tallo, órbitas y cavidades paranasales no muestra alteración.
No identifico fracturas desplazadas o deprimidas de la bóveda craneana.
Informe firmado electrónicamente por:
RUBEN DAVID GOMEZ ARDILA
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 052566/2008
Fecha y hora de firma: 08-03-2026 21:54

ESTUDIO: TAC DE CRANEO SIMPLE INGRESO
NOMBRE: SANTIAGO GARCIA PAPAMIJA
DOCUMENTO: TI 1109922924 EDAD: 15 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-07 01:11 H
ENTIDAD:
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
LTDA ENTIDAD COOPERATIVA
DLP 1627.72 mGy.cm.
TÉCNICA:
En tomógrafo multidetector y sin la aplicación de material de contraste se realizan cortes axiales desde la base del cráneo hasta el vértex con posteriores reconstrucciones multiplanares, observando:
HALLAZGOS:
Fractura deprimida de la pared posterior del seno frontal derecho con hemoseno secundario.
Hay también un pequeño foco de hemorragia subaracnoidea frontal adyacente al trazo de fractura.
La diferenciación de la sustancia gris y la sustancia blanca es adecuada.
La profundidad del espacio subaracnoideo es adecuada y guarda proporción con la amplitud del sistema ventricular.
No se identifican colecciones epi ni subdurales.
Lo visualizado del tallo y el cerebelo no presenta alteraciones.
Celdillas mastoideas no presentan alteraciones.
Hay hemoseno maxilar y esfenoidal izquierdos.
Fractura de rasgo oblicuo no desplazada del piso de la órbita derecha y la pared anterior del seno maxilar derecho, que se extiende medialmente, afectando el conducto nasolacrimal.
Se observa también fractura de la pared anterior del seno maxilar izquierdo con hemoseno secundario.
Edema de los tejidos blandos de la región frontal en el lado derecho.
OPINIÓN:
1. Pequeño foco de hemorragia subaracnoidea frontal derecha.
2. Fractura conminuta y deprimida de la pared posterior del seno frontal derecho.
3. Fractura de la pared anterior del seno maxilar izquierdo con hemoseno secundario.
4. Fractura del piso de la órbita derecha y la pared anterior del seno maxilar derecho, que se extiende medialmente, afectando el conducto nasolacrimal.
Informe firmado electrónicamente por:
SANDRA ELIZABETH GIRALDO REYES
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 29927483
Fecha y hora de firma: 08-03-2026 13:48

TAC DE COLUMNA CERVICAL
ESTUDIO: TAC DE COLUMNA CERVICAL (TRES ESPACIOS + CUATRO ESPACIOS ADICIONALES)
NOMBRE: SANTIAGO GARCIA PAPAMIJA
DOCUMENTO: TI 1109922924 EDAD: 15 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-07 01:11 H
ENTIDAD:
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
LTDA ENTIDAD COOPERATIVA
DLP 1627.72 mGy.cm
TÉCNICA:
En tomógrafo multidetector de se realizan cortes axiales finos en la región cervical desde C1 hasta C7 con posterior reconstrucciones multiplanares en estación de trabajo, observando:
HALLAZGOS:

Los cuerpos vertebrales y elementos posteriores son de patrón trabecular normal, sin identificarse lesiones líticas, blásticas ni trazos de fractura.
Las articulaciones facetarias y uncovertebrales se conservan.
Los agujeros vertebrales tienen aspecto normal.
Los espacios intervertebrales se encuentran conservados.
La amplitud del canal medular y los neuroforámenes es normal, sin lesiones ocupantes de espacio, lesiones epi o subdurales.
No hay trastornos de la alineación.
Los tejidos blandos paravertebrales no presentan alteraciones.
OPINIÓN:
1. TOMOGRAFÍA DE COLUMNA CERVICAL DENTRO DE PARÁMETROS NORMALES.
Informe firmado electrónicamente por:
SANDRA ELIZABETH GIRALDO REYES
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 29927483
Fecha y hora de firma: 08-03-2026 11:19

ESTUDIO: TAC DE ORBITAS
NOMBRE: SANTIAGO GARCIA PAPAMIJA
DOCUMENTO: TI 1109922924 EDAD: 15 AÑOS
FECHA ESTUDIO: 2026-03-07 11:30 H
ENTIDAD:
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
LTDA ENTIDAD COOPERATIVA
TÉCNICA:
En tomógrafo multidetector, se realizan cortes axiales y coronales de 3 y 5mm. En región orbitaria, posteriormente se realizan reconstrucciones coronales y sagitales.
HALLAZGOS:
Fractura que compromete la pared medial de la órbita derecha con desplazamiento de fragmentos óseos.
Globos oculares de aspecto normal.
Planos musculares y espacio intra y extraconal sin alteraciones.
Fractura que compromete la pared posterior del seno frontal derecho con ocupación con material con densidad de tejidos blandos.
Ocupación con material con densidad de tejidos blandos en los senos paranasales de predominio en el seno esfenoidal, celdillas etmoidales y seno maxilar izquierdo.
Septo nasal central.
Cambios inflamatorios en los tejidos blandos.
Hematoma subgaleal frontal derecho.
CONCLUSIÓN:
1. Fractura de la pared medial de la órbita derecha.
2. Fractura del seno esfenoidal derecho en su pared posterior.
3. Hemoseno.
nforme firmado electrónicamente por:
RUBEN DAVID GOMEZ ARDILA
MEDICO RADIOLOGO
No. registro: 052566/2008
Fecha y hora de firma: 08-03-2026 21:05

2026-03-10 08:41	**PROFESIONAL:** fraquipo - FRANCISCO JAVIER QUINTERO PORTILLA	**ESPECIALIDAD:** MEDICINA GENERAL

EVOLUCION UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS - PEDIATRICO - DIA -
DRA. ANNY QUIÑONES (MD ESPECIALISITA) - FRANCISCO QUINTERO P (MD ASISTENCIAL)

NOMBRE: SANTIAGO GARCIA PAPAMIJA
EDAD: 15 AÑOS
DOCUMENTO: 1109922924
ENTIDAD: SOAT
ACUDIENTE: MADRE - 3128845383
FECHA DE INGRESO A URGENCIAS: 07/03/2026
FECHA DE INGRESO UCI: 08/03/2026

* DIAGNOSTICOS:

-POLITRAUMATISMO POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO
-TRAUMA CRANEOENCEFALICO MODERADO
-NEUMOENCÉFALO FRONTAL DERECHO
-PEQUEÑO FOCO DE CONTUSIÓN HEMORRÁGICA FRONTAL DERECHA
TRAUMA FACIAL
-FRACTURA PARED POSTERIOR DEL SENO FRONTAL DERECHO
-FRACTURA NO DESPLAZADA DE LA PARED POSTERO-LATERAL Y ANTERIOR DEL SENO MAXILAR IZQUIERDO.
-FRACTURA NO DESPLAZADA DEL PISO DE LA ORBITA DERECHA.
-HERIDA COMPLEJA PROFUNDA FRONTAL DERECHA
—POP DESBRIDAMIENTO + COLGAJO DE HERIDA FRONTAL DERECHA (DRA MUÑOZ - 09/03/2026)
-HEMATOMA PABELLÓN AURICULAR DERECHO
—POP DRENAJE DE HAMATOMA PERICONDRAL (DRA MUÑOZ - 09/03/2026)
TRAUMA EN HOMBRO DERECHO
-FRACTURA DE TERCIO DISTAL DE LA CLAVÍCULA- MANEJO CONSERVADOR

* CRIETERIOS UCIN
.- MONITORIZACION NEUROLOGICA NO INVASIVA
.- MONITORIZACION HEMODINAMICA NO INVASIVA

* INVASIONES
- CATETER VENOSO PERIFERICO MSI - FI 07/03/2026

* SOPORTES
- NINGUNO

* SUBJETIVO: PACIENTE REFIERE QUE PASA BUENA NOCHE, LOGRA ADECUADA CONCILIACION DE SUEÑO, TOLERANDO LA VIA ORAL, DOLOR MODULADO

* OBJETIVO: PACIENTE EN CAMA EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES DE MOMENTO SIN SIGNOS DE FOCALIZACION NEUROLOGICA, NO SIGNOS DE BAJO GASTO, DOLOR MODULADO EVA 3/10.

*EXAMEN FISICO

SIGNOS VITALES:
PRESIÓN ARTERIAL: 108/59 MMHG (PAM 75 MMHG)
FRECUENCIA CARDIACA: 69 LATIDOS/MINUTO
FRECUENCIA RESPIRATORIA 19 RESPIRACIONES/MINUTO
SATURACIÓN DE O2 98% FiO2 0.21%
TEMPERATURA 36.4 °C

PESO 65 KG - TALLA 165 CM

BALANCE HÍDRICO EN 24 HORAS:
LIQUIDOS ADMINISTRADOS: 3170CC
LIQUIDOS ELIMINADOS: 2310CC
BALANCE DIA: + 860CC
BALANCE ACUMULADO: 2190 + CC
GU: 1.4CC/KG/H

CABEZA Y ORL: HERIDA EN REGIÓN FRONTAL SUTURADA CUBIERTA CON APOSTIO ESTERIL SIN ESTIGMAS DE SANGRADO, OREJA DERECHA CON APOSITO SIN SANGRADO, ESCLERAS ANICTERICAS, MUCOSAS HUMEDAS, CONJUNTIVAS ROSADAS.
- HEMODINAMICO: SIN SOPORTE VASAOCTIVO, SIN SIGNOS DE BAJO GASTO, NO FRIALDAD DISTAL, LLENADO CAPILAR MENOR DE 3 SEGUNDOS, PULSOS SIMETRICOS REGULARES, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS
- RESPIRATORIO: TORAX SIMETRICO, NORMOEXPANSIBLE, SIN TIRAJES, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO, SIN SOBREAGREGADOS.
- GASTROINTESTINAL: ABDOMEN NO DISTENDIDO, BLANDO, DEPRESIBLE, SIN LLANTO A LA PALPACION, NO IRRITACION PERITONEAL.
- RENAL: MICCION ESPONTANEA, ORINA CLARA, NO EDEMAS.
- METABOLICO: TOLERANDO LAL VIA ORAL, NO EMESIS.
- HEMATOLOGICO: NO SANGRADO, NO HEMATOMAS
- INFECCIOSO: SIN DISTERMIAS, AFEBRIL.
- OSTEOMUSCULAR: HOMBRO DERECHO: EDEMA, CREPITACION, DOLOR A LA PALPACION, ARCOS DE MOVILIDAD ARTICULAR LIMITADOS, NO DEFICIT NEUROVASCULAR DISTAL, LLENADO CAPILAR MENOR DE 3 SEGUNDOS. INMOVILIZADO .RESTO DE EXTREMIDADES SIMETRICAS, MOVILES Y SIN EDEMAS.
- NEUROLOGICO: ALERTA, ACTIVO, REACTIVO, SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE
-PIEL: HERIDA COMPLEJA PROFUNDA EN REGION FRONTAL DERECHA CON BORDES IRREGULARES AVULSIVOS, TIENE CURACION, HAY EDEMA Y EQUIMOSIS PALPEBRAL ASOCIADA.

ANTIBIÓTICO
-AMPICILINA/SULBACTAM (FI: 08/03/2026). - ACTIVO

* ANALISIS

PACIENTE DE 15 AÑOS, POLITRAUMATISMO POR ACCIDENTE DE TRANSITO, AHORA CON LA SIGUIENTE CONDICIÓN CLÍNICA:

- TRAUMA CRANEOENCEFALICO MODERADO CON TAC DE CRANEO QUE EVIDENCIA NEUMOENCÉFALO PEQUEÑO A NIVEL FRONTAL CON CONTUSIÓN HEMORRÁGICA ASOCIADA, SIN EDEMA CEREBRAL, LINEA MEDIA CENTRADA, NO LESIONES OCUPANTES DE ESPACIO, SIN CRITERIO DE MANEJO QUIRÚRGICO POR NEUROCIRUGIA, DR. ORDOÑEZ, SE REALIZA TAC DE CRANEO DE CONTROL TRAS 12 H SIN EVIDENCIA DE AUMENTO DE LESIONES YA CONOCIDAS, SE COMENTAN HALLAZGOS CON ESPECIALIDAD INTERCONSULTANTE, INDICA ALTA POR ESPECIALIDAD ACTUALMENTE SIN DETERIORO NEUROLÓGICO, SIN CEFALEA, TOLERANDO LA VIA ORAL, SIN SIGNOS DE HIPERTENSIÓN ENDOCRANEANA.

- TRAUMA FACIAL CON TAC DE CARA QUE EVIDENCIA FRACTURA PARED POSTERIOR DEL SENO FRONTAL DERECHO, FRACTURA NO DESPLAZADA DE LA PARED POSTERO-LATERAL Y ANTERIOR DEL SENO MAXILAR IZQUIERDO, FRACTURA NO DESPLAZADA DEL PISO DE LA ORBITA DERECHA, CON HERIDA COMPLEJA PROFUNDA FRONTAL YA DESCRITA, HALLAZGO COMENTADO CON EL SERVICIO DE CIRUGÍA MAXILOFACIAL (DR BENJUMEA) QUIEN CONSIDERA DAR MANEJO CONSERVADOR, CURSA ADEMÁS CON HERIDA EN REGION FRONTAL VALORADA POR CX PLASTICA QUIEN REALIZA DESBRIDAMIENTO + COLGAJO DE HERIDA FRONTAL DERECHA. Y DRENAJE DE HEMATOMA EN PABELLON AURICULAR DERECHO SIN COMPLICACIONES . DIO ALTA POR ESPECIALIDAD.

- TRAUMA EN HOMBRO DERECHO CON RADIOGRAFÍA DE HOMBRO QUE EVIDENCIA FRACTURA DE TERCIO DISTAL DE CLAVÍCULA DERECHA, SE SOLICITA INTERCONSULTA POR ORTOPEDIA INFANTIL, SE COMENTA HALLAZGOS CON DR. PRADO, QUIEN INDICA MANEJO CONSERVADOR, USO DE INMOVILIZADOR DE HOMBRO Y CONTROL AMBULATORIO POR LA ESPECIALIDAD, INCAPACIDAD MEDICA POR 30 DIAS. SE CONTINUA ANALGESIA.

PACIENTE CON EVOLUCION CLINICA SATISFACTORIA POR LO QUE SE INDICA TRASLADO A SALA DE HOSPITALIZACION PEDIATRIA PARA CONTINUAR MANEJO INTEGRAL, SE COMENTA CONDUCTA MEDICA A SEGUIR A PACIENTE Y FAMILIAR QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTA.

2026-03-10 09:42	**PROFESIONAL:** marmulta - MARIA GISELL MURILLO TAMAYO	**ESPECIALIDAD:** FISIOTERAPIA

TERAPIA RESPIRATORIA DIA

PACIENTE SANTIAGO GARCIA PAPAMIJA DE GENERO MASCULINO DE 15 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICOS MEDICOS ANOTADOS PREVIAMENTE EN LA HISTORIA CLINICA, ENCUENTRO PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES DE SALUD EN GENERAL, HEMODINAMICAMENTE ESTABLE SIN SOPORTE DE VASOPRESOR, SIN SOPORTE DE SEDOANALGESIA EN EL SISTEMA NEUROLOGICO SE

ENCUENTRA EN GLASGOW DE 15/15 COLABORADORA LOGRA OBEDECER ORDENES COMPLEJAS, LOGRA INTERACTUAR CON EL ENTORNO, EN EL SISTEMA CARDIVASCULAR SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES SIGNOS VITALES: TA 120/70, FC 89, FR 19, EN EL SISTEMA PULMONAR SE ENCUENTRA SIN SOPORTE DE OXIGENO, AIRE AMBIENTE, FIO2 21% SATURANDO ENTRE 96-99 A LA AUSCULTACION SE ENCUENTRA MURMULLO VESICULAR CONSERVADO EN AMBOS CAMPOS PULMONARES SIN PRESENCIA DE RUIDOS SOBRE AGREGADOS, TORAX SIMETRICO NORMOEXPANSIBLE, PATRON RESPIRATORIO RITMICO TORACOABDOMINAL SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA.

OBJETIVOS:
FAVORECER LA REEXPANSION PULMONAR
GARANTIZAR INTERCAMBIO GASEOSO

INTERVENCIÓN TERAPEUTICA
--MONITORIA RESPIRATORIA
--POSICIONAMIENTO EN CAMA EN SEMIFOWLER A 45°
--FISIOTERAPIA RESPIRARTORIA CON MOVILIZACIÓN DE REJA COSTAL
--ACELERACIÓN DE FLUJO ESPIRATORIO LENTO COMO TECNICA DE DESOBTRUCCION BRONQUIAL SIN MOVILIZAR SECRECIONES
--EJERCICIOS DE REEXPANSION PULMONAR CON INSPIRACIONES PROFUNDAS SOSTENIDAS 3 SERIES / 10 REPETICIONES
--INSPIRACIONES FRACCIONADAS Y SUSPIROS PROFUNDOS 3 SERIES / 10 REPETICIONES
-- EJERCICIOS INSPIRACIONES SOSTENIDAS, CON EXPIRACIONES FRACCIONADAS 3 SERIES / 10 REPETICIONES

PACIENTE TOLERA INTERVENCION, QUEDA ESTABLE DENTRO DE SU CUADRO CLÍNICO.

DIAGNOSTICOS DE EGRESO ASIGNADOS	
CODIGO	DIAGNOSTICO DE EGRESO
S018	HERIDA DE OTRAS PARTES DE LA CABEZA
S099	TRAUMATISMO DE LA CABEZA NO ESPECIFICADO
S199	TRAUMATISMO DEL CUELLO NO ESPECIFICADO
S499	TRAUMATISMOS NO ESPECIFICADOS DEL HOMBRO Y DEL BRAZO

FECHA	RESUMEN DEL PLAN TERAPEUTICO
2026-03-07	21:30 johmonmi - JOHN CARLOS MONSALVE MIRANDA ESPECIALIDAD: PEDIATRIA PESO: 65 KGS -INGRESAR A SALA DE OBSERVACION PEDIATRIA -NADA VIA ORAL -L.E.V.: LACTATO DE RINGER INFUSION CONTINUA A 80 CC HORA -DICLOFENAC AMP 75 MG: DILUIR EN 100 CC DE SSN Y ADMINISTRAR EN INFUSION ENDOVENOSA DE 20 MIN AHORA -DIPIRONA AMP 1 GR: DILUIR HASTA 100 CC EN SSN Y ADMINISTRAR EN INFUSION ENDOVENOSA DE 20 MIN CADA 6 HORAS -CEFAZOLINA AMP 1 GR: ADMINISTRAR 1 GR ENDOVENOSO LENTO CADA 6 HORAS -TOXOIDE TETANICO AMP 40 UI: ADMINISTRAR INTRAMUSCULAR DOSIS UNICA -CUIDADOS POR ENFERMER?A -CONTROL DE SIGNOS VITALES CADA 4 HORAS -CURACION DE LESIONES EN PIEL POR ENFERMERIA -HOJA NEUROLOGICA HORARIA -SS: HEMOGRAMA Y TIEMPOS DE COAGULACION -SS: TOMOGRAFIAS SIMPLES DE CRANEO, CUELLO Y ORBITA DERECHA -SS: Rx DEL HOMBRO DERECHO -SS: Vx CIRUGIA PLASTICA -SEGUIMIENTO POR PEDIATRIA / MED GENERAL -GRACIAS
2026-03-08	03:28 johmonmi - JOHN CARLOS MONSALVE MIRANDA ESPECIALIDAD: PEDIATRIA PESO: 65 KGS -HOSPITALIZAR EN CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRICO -NADA VIA ORAL -L.E.V.: LACTATO DE RINGER INFUSION CONTINUA A 80 CC HORA -DICLOFENAC AMP 75 MG: DILUIR EN 100 CC DE SSN Y ADMINISTRAR EN INFUSION ENDOVENOSA DE 20 MIN CADA 12 HORAS -DIPIRONA AMP 1 GR: DILUIR HASTA 100 CC EN SSN Y ADMINISTRAR EN INFUSION ENDOVENOSA DE 20 MIN CADA 6 HORAS -CEFAZOLINA AMP 1 GR: ADMINISTRAR 1 GR ENDOVENOSO LENTO CADA 6 HORAS -CUIDADOS POR ENFERMER?A -MONITORIA CONTINUA DE SIGNOS VITALES -HOJA NEUROLOGICA HORARIA -SS: Vx CIRUGIA MAXILOFACIAL -SS: TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE DE CONTROL A LAS 13:00 -PTE: NOTA FORMAL DE NEUROCIRUGIA -PTE: HEMOGRAMA Y TIEMPOS DE COAGULACION -PTE: LECTURA DE TOMOGRAFIAS SIMPLES DE CRANEO, CUELLO Y ORBITA DERECHA -PTE: LECTURA DE Rx DEL HOMBRO DERECHO -SEGUIMIENTO POR PEDIATRIA / MED GENERAL -GRACIAS

05:10 diadonca - DIANA MARCELA DONNEYS CASTAÑO
ESPECIALIDAD: PEDIATRIA

PESO 65 KG
LEV TOTAL 80 CC / H

-VIA OAL CON DIETA BLANDA VIGILANDO TOLERANCIA
-CABECERA A 45 GRADOS
-LACTATO PARA COMPLETAR APORTE H?DRICO
-AMPICILINA / SULBACTAM 3 GR CADA 6 HORAS FI: 08/03/2026
-DIPIRONA 1 GR EV CADA 8 HORAS
-PARACETAMOL 1 GR CADA 6 HORAS
-MORFINA 3 MG EV CADA 4 HORAS SI EVA >4, MAXIMO 4 DOSIS DE RESCATE
-HOJA NEUROLOICA CADA 1 HORA.
-GLUCOMETRIA CADA 6 HORAS
-CUIDADOS DE HERIDAS POR ENFERMER?A
-PREVENCI?N DE CA?DAS Y DE ZONAS DE PRESI?N.
-ACOMPA?ANTE PERMANENTE.
-EDUCACI?N A LA FAMILIA DEL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNA
-BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCI?N DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
-MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO PEDI?TRICO

EN PROCESO
TAC DE CONTROL A LAS 13+00 HORAS
LECTURA DE TAC DE CRANEO, ORBITA , CERVICAL Y RX DE HOMBRO DERECHO

SE SOLICITA
VALORACI?N POR CIRUG?A PL?STICA Y MAXILOFACIAL

SEGUIMIENTO
NEUROCIRUGIA

METAS DE MONITOREO NEUROCRITICO
TAM DE 65-95 MG
GLUCOMETRIA 110 -180 MG/DL.
DIURESIS 0.5 A 1CC/KG/H EN PLAN DE BALANCE NEUTRO
EVA <4
SATURACI?N >90%

GRACIAS!

MEDICAMENTO FORMULADO: PARACETAMOL 1000MG SOLUCION INYECTABLE 100ML-FRESENIUS 1 SOLUCION - LAB. :VARIOS 1 SOLUCION Cada 6 Hora(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 1000mg SOLUCION, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
MEDICAMENTO FORMULADO: AMPICILINA 1G + SULBACTAM 0.5G POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR VIAL-FARMALOGICA 1 VIAL - LAB. :VARIOS 2 VIAL Cada 6 Hora(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 1g/0,5mg VIAL, DIAS DE TRATAMIENTO: 1
OBSERVACIONES: 3 GR CADA 6 HORAS

10:57 josnarba - JOSE GERMAN NARVAEZ BASTIDAS
ESPECIALIDAD: PEDIATRIA

PLAN TERAPEUTICO - UCIP
PESO 65 KG

-DIETA CORRIENTE.
-CABECERA A 45?
-AMPICILINA/SULBACTAM 3 G (CON BASE A AMPICILINA), C/6H, IV (FI: 08/03/2026).
-DIPIRONA 1 G, C/6H, IV.
-PARACETAMOL 1 G, C/6H, IV.
-HOJA NEUROLOGICA CADA 2 HORAS.
-SUSPENDER LEV Y DEJAR TAPON VENOSO.
-GLUCOMETRIA CADA 12 HORAS
-CUIDADOS DE HERIDAS POR ENFERMER?A
-PREVENCI?N DE CA?DAS Y DE ZONAS DE PRESI?N.
-ACOMPA?ANTE PERMANENTE.
-EDUCACI?N A LA FAMILIA DEL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNA
-BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCI?N DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
-MONITORIA CONTINUA DE SIGNOS VITALES.
-CUANTIFICAR LIQUIDOS ADMINISTRADOS Y ELIMINADOS.
-EN PROCESO VALORACI?N POR CIRUG?A PL?STICA Y MAXILOFACIAL. TAC DE CRANEO SIMPLE DE CONTROL A LAS 13 HORAS
-SEGUIMIENTO POR NEUROCIRUGIA

*METAS TERAPEUTICAS:
-TAM DE 75-95 MMHG
-GLUCOMETRIA: 110 -180 MG/DL.
-DIURESIS 1-2 CC/KG/H.
-EVA: <4
-SO2: >94%.

12:28 josnarba - JOSE GERMAN NARVAEZ BASTIDAS
ESPECIALIDAD: PEDIATRIA

MEDICAMENTO FORMULADO: CLORURO DE SODIO 0.9 % SOLUCION INYECTABLE BOLSA X 250ML-BAXTER 1 SOLUCION - LAB. :VARIOS 1 SOLUCION Cada 6 Hora(s), VIA: INTRAVENOSA, CONCENTRACIÓN 0.9 % SOLUCION, DIAS DE TRATAMIENTO: 1

12:41 josnarba - JOSE GERMAN NARVAEZ BASTIDAS
ESPECIALIDAD: PEDIATRIA

Solucitud Apoyo Dx: TOMOGRAFIA COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE
**Obs: TOMOGRAFIA COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE CONTROL DE 24 HORAS

20:37 diadonca - DIANA MARCELA DONNEYS CASTAÑO
ESPECIALIDAD: PEDIATRIA

PLAN TERAPEUTICO - UCIP
PESO 65 KG

-DIETA CORRIENTE.
-CABECERA A 45?
-AMPICILINA/SULBACTAM 3 G (CON BASE A AMPICILINA), C/6H, IV (FI: 08/03/2026).
-DIPIRONA 1 G, C/6H, IV.
-PARACETAMOL 1 G, C/6H, IV.
-HOJA NEUROLOGICA CADA 2 HORAS.
-CUIDADOS DE HERIDAS POR ENFERMER?A
-PREVENCI?N DE CA?DAS Y DE ZONAS DE PRESI?N.
-ACOMPA?ANTE PERMANENTE.
-EDUCACI?N A LA FAMILIA DEL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNA
-BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCI?N DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
-MONITORIA CONTINUA DE SIGNOS VITALES.
-CUANTIFICAR LIQUIDOS ADMINISTRADOS Y ELIMINADOS.

EN PROCESO:
REPORTE DE TAC DE CONTROL
INTERVENCION QUIRURGICA POR CIRUGIA PLASTICA

-SEGUIMIENTO
NEUROCIRUGIA

*METAS TERAPEUTICAS:
-TAM DE 75-95 MMHG
-GLUCOMETRIA: 110 -180 MG/DL.
-DIURESIS 1-2 CC/KG/H.
-EVA: <4
-SO2: >94%.

GRACIAS!

23:55 sebmonvi - SEBASTIAN MONTES VILLEGAS
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

Neurologico : Cada 2 horas
Solicitud Proc Qx: DESBRIDAMIENTO ESCISIONAL EN AREA ESPECIAL EN CARA Y CUELLO
**Obs:
Solicitud Proc Qx: DESBRIDAMIENTO ESCISIONAL EN AREA ESPECIAL EN CARA Y CUELLO
**Obs:
Solicitud Proc Qx: DESBRIDAMIENTO ESCISIONAL EN AREA ESPECIAL EN CARA Y CUELLO
**Obs: HERIDA COMPLEJA PROFUNDA EN REGION FRONTAL DERECHA
Solicitud Proc Qx: COLGAJO LOCAL DE PIEL COMPUESTO DE VECINDAD ENTRE CINCO A DIEZ CENTIMETROS CUADRADOS
**Obs:

2026-03-09

01:06 sebmonvi - SEBASTIAN MONTES VILLEGAS
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

Solicitud Interconsulta por: CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL
**Obs: interconsulta retrospectiva ya resuelta
Solicitud Interconsulta por: NEUROCIRUGIA
**Obs: contusion hemorragica frontal izquierda, fractura de pared posterior de seno frontal, valoracion retrospectiva ya resuelta

07:51 milmoltr - MILTON MOLANO TRUJILLO
ESPECIALIDAD: CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

PLAN TERAPEUTICO - UCIP
PESO 65 KG

-ESTANCIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIOS
-NADA VIA ORAL REINICIAR DIETA CORRIENTE POSTERIOR A CIRUGIA
-CABECERA A 45?
-AMPICILINA/SULBACTAM 3 G (CON BASE A AMPICILINA), C/6H, IV (FI: 08/03/2026).
-DIPIRONA 1 G, C/6H, IV. FECHA DE INICIO 9 DE MARZO DEL 2026 (SUSPENDER 14 MARZO 2026)
-PARACETAMOL 1 G, C/6H, IV.
-HOJA NEUROLOGICA CADA 2 HORAS.
-CUIDADOS DE HERIDAS POR ENFERMER?A

-VALORACION DE DOLOR CON ESCALA EVA META MENOR DE 4
-MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DE DOLOR
-PREVENCI?N DE CA?DAS Y DE ZONAS DE PRESI?N.
-ACOMPA?ANTE PERMANENTE.
-EDUCACI?N A LA FAMILIA DEL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNA
-BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCI?N DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
-MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIOS

EN PROCESO:
INTERVENCION QUIRURGICA POR CIRUGIA PLASTICA

-SEGUIMIENTO
NEUROCIRUGIA

*METAS TERAPEUTICAS:
-TAM DE 75-95 MMHG
-GLUCOMETRIA: 110 -180 MG/DL.
-DIURESIS 1-2 CC/KG/H.
-EVA: <4
-SO2: >94%.

GRACIAS!

07:55 milmoltr - MILTON MOLANO TRUJILLO
ESPECIALIDAD: CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

PLAN TERAPEUTICO - UCIP
PESO 65 KG

-ESTANCIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIOS
-NADA VIA ORAL REINICIAR DIETA CORRIENTE POSTERIOR A CIRUGIA
-CABECERA A 45?
-LACTATO DE RINGER A 80 CC / H
-AMPICILINA/SULBACTAM 3 G (CON BASE A AMPICILINA), C/6H, IV (FI: 08/03/2026).
-DIPIRONA 1 G, C/6H, IV. FECHA DE INICIO 9 DE MARZO DEL 2026 (SUSPENDER 14 MARZO 2026)
-PARACETAMOL 1 G, C/6H, IV.
-HOJA NEUROLOGICA CADA 2 HORAS.
-CUIDADOS DE HERIDAS POR ENFERMER?A
-VALORACION DE DOLOR CON ESCALA EVA META MENOR DE 4
-MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DE DOLOR
-PREVENCI?N DE CA?DAS Y DE ZONAS DE PRESI?N.
-ACOMPA?ANTE PERMANENTE.
-EDUCACI?N A LA FAMILIA DEL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNA
-BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCI?N DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
-MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIOS

EN PROCESO:
INTERVENCION QUIRURGICA POR CIRUGIA PLASTICA

-SEGUIMIENTO
NEUROCIRUGIA

*METAS TERAPEUTICAS:
-TAM DE 75-95 MMHG
-GLUCOMETRIA: 110 -180 MG/DL.
-DIURESIS 1-2 CC/KG/H.
-EVA: <4
-SO2: >94%.

GRACIAS!

20:32 annquiri - ANNI KARINA QUIÑONES RINCON
ESPECIALIDAD: PEDIATRIA

PLAN TERAPEUTICO - UCIP
PESO 65 KG

-ESTANCIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIOS
-DIETA PARA LA EDAD
-CABECERA A 45?
-LACTATO DE RINGER A 80 CC / H
-AMPICILINA/SULBACTAM 3 G (CON BASE A AMPICILINA), C/6H, IV (FI: 08/03/2026).
-DIPIRONA 1 G, C/6H, IV. FI 07/03/26 (SUSPENDER 13 MARZO 2026)
-PARACETAMOL 1 G, C/6H, IV.
-HOJA NEUROLOGICA CADA 2 HORAS.
-CUIDADOS DE HERIDAS POR ENFERMER?A
-VALORACION DE DOLOR CON ESCALA EVA META MENOR DE 4
-MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DE DOLOR
-PREVENCI?N DE CA?DAS Y DE ZONAS DE PRESI?N.
-ACOMPA?ANTE PERMANENTE.

	-EDUCACI?N A LA FAMILIA DEL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNA -BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCI?N DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD -MONITORIA DE UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIOS -SEGUIMIENTO NEUROCIRUGIA *METAS TERAPEUTICAS: -TAM DE 75-95 MMHG -GLUCOMETRIA: 110 -180 MG/DL. -DIURESIS 1-2 CC/KG/H. -EVA: <4 -SO2: >94%. GRACIAS!
2026-03-10	08:00 fraquipo - FRANCISCO JAVIER QUINTERO PORTILLA ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL PLAN TERAPEUTICO - UCIN PEDIATRIA PESO 65 KG -TRASLADO A SALA DE HOSPITALIZACION ****** NUEVO ***** -DIETA PARA LA EDAD -CABECERA A 45? -LACTATO DE RINGER A 80 CC / H ***** SUSPENDER ***** -AMPICILINA/SULBACTAM 3 G (CON BASE A AMPICILINA), C/6H, IV (FI: 08/03/2026). -DIPIRONA 1 G, C/6H, IV. FI 07/03/26 (SUSPENDER 13 MARZO 2026) -PARACETAMOL 1 G, C/6H, IV. -CUIDADOS DE HERIDAS POR ENFERMER?A -VALORACION DE DOLOR CON ESCALA EVA META MENOR DE 4 -MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DE DOLOR -PREVENCI?N DE CA?DAS Y DE ZONAS DE PRESI?N. -ACOMPA?ANTE PERMANENTE. -EDUCACI?N A LA FAMILIA DEL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNA -BUNDLES INTERNACIONALES PARA LA PREVENCI?N DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD *METAS TERAPEUTICAS: -TAM DE 75-95 MMHG -GLUCOMETRIA: 110 -180 MG/DL. -DIURESIS 1-2 CC/KG/H. -EVA: <4 -SO2: >94%. GRACIAS !!! Solicitud Proc No Qx: 130A02-INTERNACION PEDIATRICA COMPLEJIDAD ALTA HABITACION MULTIPLE
2026-03-11	07:28 milmoltr - MILTON MOLANO TRUJILLO ESPECIALIDAD: CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO PLAN TERAPEUTICO - UCIN PEDIATRIA PESO 65 KG -TRASLADO A SALA DE HOSPITALIZACION -DIETA PARA LA EDAD -CABECERA A 45? -AMPICILINA/SULBACTAM 3 G (CON BASE A AMPICILINA), C/6H, IV (FI: 08/03/2026). COMPLETAR 5 DIAS -DIPIRONA 1 G, C/6H, IV. FI 07/03/26 (SUSPENDER 13 MARZO 2026) -PARACETAMOL 1 G, C/6H, IV. -CUIDADOS DE HERIDAS POR ENFERMER?A -VALORACION DE DOLOR CON ESCALA EVA META MENOR DE 4 -MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS PARA LA PREVENCION DE DOLOR -PREVENCI?N DE CA?DAS Y DE ZONAS DE PRESI?N. -ACOMPA?ANTE PERMANENTE. *METAS TERAPEUTICAS: -TAM DE 75-95 MMHG -GLUCOMETRIA: 110 -180 MG/DL. -DIURESIS 1-2 CC/KG/H. -EVA: <4 -SO2: >94%. GRACIAS !!!

NO HAY RESULTADOS DE EXAMEN FISICO

REVISION POR SISTEMA DEL PACIENTE		
SISTEMA	OBSERVACION	FECHA REGISTRO
Neurologico	NIEGA	07/03/2026 20:59
Nervioso Central y Periferico	NIEGA	07/03/2026 20:59
Organos de los Sentidos	NIEGA	07/03/2026 20:59
CardioVascular	NIEGA	07/03/2026 20:59
Respiratorio	NIEGA	07/03/2026 20:59
GastroIntestinal	NIEGA	07/03/2026 20:59
GenitoUrinario	NIEGA	07/03/2026 20:59
OsteoMuscular	NIEGA	07/03/2026 20:59
Esfera Mental	NIEGA	07/03/2026 20:59
Piel	NIEGA	07/03/2026 20:59
Sistema Endocrino	NIEGA	07/03/2026 20:59
General	NIEGA	07/03/2026 20:59

YO MILTON MOLANO TRUJILLO CERTIFICO QUE EL SEï¿½OR SANTIAGO GARCIA PAPAMIJA IDENTIFICADO CON TARJETA DE IDENTIDAD NUMERO 1109922924, HA SUFRIDO DAï¿½O EN SU INTEGRIDAD FISICA COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE UN ACCIDENTE DE TRANSITO

PROFESIONAL : MILTON MOLANO TRUJILLO

CC - 7698361 - T.P 07698361

ESPECIALIDAD - CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO

Imprimiï¿½: ANDREA LIZETH MALLAMA CARDENAS - andmalca

Fecha Impresiï¿½n : 2026/3/11 - 08:02:10